

Phénoménologie et analyse existentielle III

Livret d'accompagnement du CM 2026-2027

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

Présentation

CM :

Partie I : figures cliniques majeures (fatigue, dépression) comme altérations de la tenue du monde quotidien

Partie II : phénoménologie du quotidien, centrée sur les formes ordinaires de la familiarité et de la praticabilité du monde

Partie III : phénoménologie de l'habiter, prolongeant l'analyse du Dasein pour penser la manière dont l'existence se tient dans des lieux, des rythmes et des relations

Partie IV : phénoménologie des névroses (phobies et hystérie), dans la perspective d'une anthropologie phénoménologique

Etudes de cas (auteurs) :

- Galliot Gaël, Gozé Tudi, « Schizophrénie et rétablissement : analyse phénoménologique d'un cas de retrait positif », *Annales Médico-Psychologiques*, 2021, n° 179, p. 401–408
- Bloc Lucas, Pringuey Dominique, Wolf-Fédida Mareike, « Phénoménologie du vécu hyperphagique dans l'obésité : le corps, le monde et l'autre », *Annales Médico-Psychologiques*, n° 176, 2018, p. 236-242.
- Englebert Jérôme, « Anorexie et intersubjectivité : étude phénoménologique et éthologique », *Annales Médico-Psychologiques*, n° 173, 2015, p. 659-664.
- Francesetti Gianni, « Une exploration phénoménologique et gestaltiste des troubles obsessionnels compulsifs », *Cahiers de Gestalt-thérapie*, n° 41, 2019/1, p. 44-75.

Sommaire

PRÉSENTATION

SOMMAIRE

I - PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA FATIGUE

1. Introduction
2. Clinique de la fatigue
3. Altérations du pouvoir : fatigue, épuisement
4. Altérations du valoir : ennui, acédie, dépression
5. Altérations conjointes : mélancolie
6. Fatigues de défense : luttés anxieuses et ruminations
7. Synthèse clinique et phénoménologique

II - PHÉNOMÉNOLOGIE DU QUOTIDIEN

1. Introduction
2. L'énigme du familier
3. Le quotidien comme « structure de l'expérience »
4. Le processus de « quotidianisation »
5. Clinique du quotidien

III - PHÉNOMÉNOLOGIE DE L'HABITER

1. Introduction
 2. L'habiter comme structure existentielle
 3. Psychopathologie de l'habiter
 4. Le « Soi territorial » et l'habitation du corps
- (Synthèse) Mr R. Analyse phénoménologique

IV - PHÉNOMÉNOLOGIE DES NÉVROSES : « L'ÊTRE EN DEÇÀ DE SOI » (PHOBIE, HYSTÉRIE)

1. La spatialité vécue. Espace empirique et espace vécu
2. Les symptômes phobiques et leurs sens anthropologique
3. La relation hystérique et phobique à la centralité

ANNEXES - USAGES PROFESSIONNELS ET LIEUX D'EXERCICE

Table des matières

I - Phénoménologie de la fatigue

1. Introduction

La phénoménologie clinique permet de distinguer, à partir d'une « clinique de la fatigue » :

- la fatigue normale
- l'épuisement
- la dépression
- et la mélancolie

Un « sentiment corporel » peu mentalisé et polymorphe

Distinction minimale :

- la fatigue comme *vécu* : registre phénoménologique
- la fatigue comme *signe* (registre sémiologique)

Les trois dimensions de l'expérience vécue de la fatigue :

- rapport au temps → *temporalité* / historialité
- le rapport à l'action → *pouvoir* (capacité, élan)
- le rapport au monde → *valoir* (sens, valeur)

2. Clinique de la fatigue

Une altération du pouvoir d'agir :

- difficulté à rassembler l'énergie pour agir
- coût subjectif de l'action
- désir de non-action ou lassitude
- sentiment d'absence de motivation

Cinq « vécus de fatigue » :

- . la pure fatigue physique
- . les réactions d'abandon
- . la fatigue psychogène non dépressive (origine psychique sans altération durable du valoir)
- . le sentiment corporel dépressif (dans un syndrome où le valoir s'éteint)
- . les fatigues de rumination (psychasthénie/névrose obsessionnelle)

2.1. Les « sentiments corporels »

Granger Bernard, Charbonneau Georges (dir.), *Phénoménologie des sentiments corporels, tome 2. Fatigue, lassitude, ennui*, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 2003.

Carrique Pierre, (dir.), *Phénoménologie des sentiments corporels, tome 3. Joie, jouissance, ivresses*, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 2010.

- ils déterminent un vécu global qui affecte l'ensemble de notre expérience
- ils s'éprouvent d'un seul tenant, de manière diffuse
- ils ne sont ni seulement corporels, ni seulement psychiques
- ils expriment une relation d'union ou de désunion avec le monde

2.1.1. Le pré-sensoriel et le sensoriel

Le pré-sensoriel (pesanteur, légèreté, contrainte...) désigne :

- notre proto-expérience du monde
- l'accord fondamental que nous avons avec lui,
- notre capacité à nous y déployer.
- > et se prolonge dans la sensorialité

Le « pré-sensoriel » est la dimension structurante du sensoriel : il correspond au sensoriel avant sa thématization en sensation

Les sentiments corporels expriment des qualités *a priori* globales de notre rapport au monde :

- entre plaisir et déplaisir
- entre jouissance et souffrance

Les sentiments corporels sont la forme originaire de notre *ouverture au monde* :

- le monde a de la valeur (« cela vaut »)
- je peux y agir (« je peux »)
- il est vivable et habitable

C'est l'« *ouverture au monde* » (Heidegger) :

- une expérience originaire
- dans laquelle la valeur du monde et le pouvoir d'agir se répondent

2.1.2. Fatigue versus sensation

La fatigue n'est pas un phénomène sensoriel périphérique. Elle affecte :

- le corps entier
- le mouvement vers le monde

- la disponibilité à l'action
- et la temporalité vécue

La fatigue n'est pas seulement ce que le corps sent : elle est la manière dont le sujet est présent à lui-même et au monde

2.2. Les vécus de fatigue

2.2.1. Fatigue et états thymiques

On peut différencier :

- les états thymiques au sens fort (mélancolie, manie)
- les dispositions ordinaires (variations d'élan, de tonus, d'appétence)

La fatigue n'est pas une humeur constituante, mais touche au même niveau de globalité que les états thymiques :

- une *historialité* marquée par l'alternance de retombée et de reprise
- pouvant être accompagnée de colorations thymiques (sérénité, désolation...)

2.2.2. La dimension pré-réflexive de la fatigue

Le vécu corporel associe :

- l'immédiateté du ressenti
- et des anticipations implicites des capacités d'action

2.3. Le « vécu de pouvoir »

Structures phénoménologiques fondamentales de l'existence :

- le vécu de valoir : ce que vaut le monde
- le vécu de pouvoir : ce qu'il est possible de faire

2.3.1. Le primat du possible

Le fondement corporel de la subjectivité : « Je peux » (Merleau-Ponty) :

- non pas un jugement réfléchi
- mais un sentiment immédiat et incarné de possibilité

Le « je peux » structure le monde vécu qui organise :

- l'espace vécu (ce qui est atteignable)
- le temps vécu (ce qui est encore possible)

Le « je peux » est une conscience corporelle immédiate du possible

2.3.2. La réduction du pouvoir-être

La fatigue est une altération du « je peux » :

- le sujet ne se vit plus comme capable de déployer des possibles
- il est livré à ce qu'il est déjà

Effet de la fatigue sur le temps et l'espace :

- l'espace ne s'ouvre plus en termes d'atteignable
- le temps ne se projette plus vers l'avenir
- le sujet est ramené au présent pesant

2.4. Le « vécu de valoir »

2.4.1. La valeur comme « appel du monde »

Dans toute action, il existe :

- une proto-expérience de valeur (une valuation implicite des choses)

- une proto-motivation qui oriente d'emblée vers un champ de possibles
- Le « cela vaut » agit comme principe de différenciation du monde :
- certaines choses apparaissent comme significatives
 - d'autres comme secondaires ou indifférentes
- > Le vécu de valoir élargit la sphère vitale dans laquelle le « je peux » peut se déployer
- L'impression vitale :

2.4.2. L'altération du valoir

Lorsque le vécu de valoir s'altère, l'indifférenciation entraîne :

- l'effacement des contrastes
- la perte de signification des choses
- et l'affaiblissement de l'élan vers l'action

3. Altérations du pouvoir : fatigue, épuisement

3.1. La fatigue physique, sans épuisement psychique

L'affectation isolée du *vécu de pouvoir* est le propre de la fatigue physique :

- il est juste mis à l'épreuve
- le monde reste chargé de sens
- > il est simplement physiquement inatteignable

Il peut y avoir (peu souvent) une évolution d'allure dépressive

3.2. Clinique différentielle

Fatigue *versus* épuisement

Aspect temporel de la fatigue :

- pas d'altération des qualités du monde
- le « vécu de pouvoir » est altéré
- aucun sentiment de fin ne s'instaure
- cette fatigue est "endurée"

Transformation de la fatigue en épuisement :

- la fatigue est temporelle
- l'épuisement est historial

3.3. Historialité de la fatigue

Le *temporel* : entre passé et avenir *versus* l'*historial* : entre début et fin

3.3.1. Le temporel

Le temporel :

= une structure de l'instant identique à lui-même dans sa relation au passé et au présent

- il est "linéaire": un présent vivant "épais" qui articule le passé (rétention) et le futur (protension)

> c'est une structure de projection de notre être

L'exemple de la mélancolie : une *affection radicale du pouvoir-être*

3.3.2. L'historial

L'historial est un « cycle de vitalité », avec :

- . commencement
- . maturation
- . densification
- . saturation

Pathologies de l'historialité :

- . le recommencement impossible
- . le recommencement permanent

L'épuisement est « historial » (un sentiment de saturation du même) :

- de la fatigue à l'épuisement (un désir de fin)
- de l'épuisement à l'abandon

3.3.3. Les réactions abandonniques

- fatigue simple : besoin de repos après un effort
- abandonnisme : réaction pathologique, anticipation de la fin avant achèvement de l'action

4. Altérations du valoir : ennui, acédie, dépression

Trois niveaux distincts :

- altérations légères (ennui, acédie, fatigue psychogène)
- dépression caractérisée (perte de sens, « à quoi bon »)
- mélancolie (altération conjointe pouvoir/valoir : thymie, culpabilité, inhibition, temporalité figée)

4.1. Le champ dépressif et la fatigue psychogène

« A quoi bon ? » : dépression, un état à mi-chemin entre le phénoménologique (le vécu du sens) et le psychologique

La fatigue psychogène : altération du valoir

La dépression : "rien ne vaut plus"

4.2. L'acédie monastique, le « démon de midi »

La tentation du découragement et de l'inaction

> fatigue psychogène de la dépression :

- une fatigue d'ennui, une fatigue sans but
- un affaiblissement du vécu de valeur

L'ennuyé souffre d'un manque de sens temporaire

5. Altérations conjointes : mélancolie

5.1. Mélancolie versus dépression

Distinction entre dépression et mélancolie :

- dépression : la valeur des actes est affaiblie ; on ne voit plus le sens de ce qu'on fait
- mélancolie : les valeurs sont maintenues ; le sujet ne peut plus les porter
 - . tout garde un sens grave
 - = un excès de sens moral : la personne est accablée par le poids de la faute (ni ennui, ni cynisme)

5.2. Fatigue ou inhibition dans la mélancolie

Tristesse vs mélancolie :

- Le mélancolique n'éprouve pas la fatigue comme telle : il n'y a ni fatigue, ni tristesse : seulement la gravité absolue d'un monde clos
- La tristesse suppose encore un monde partagé, et une valeur reconnue

En résumé :

- fatigue → encore orientée vers l'avenir (besoin de repos)
- tristesse → douleur du présent (perte de valeur)
- mélancolie → enfermement dans le passé (impossibilité de rachat)

6. Fatigues de défense : luttres anxieuses et ruminations

L'asthénie :

- un vécu à la fois corporel et psychique de fatigue
- une absence de forces pour agir
- mais une dépense d'énergie interne continue
- = l'effet d'activités compulsives

Une énergie de distanciation sans finalité

Une fatigue de rumination : la psychasthénie

Un effort permanent de « tenir le monde à distance » :

- chez l'obsessionnel, un travail incessant de mise à distance de la saleté, des pulsions, du désordre vivant
- chez le sensitif, un combat pour survivre face à la proximité d'autrui
- = une fatigue de « remondéisation » (reconstituer un monde cohérent)

Une « fatigue ontologique » = une fatigue du maintien de soi dans l'être

Une fatigue qui traduit un travail constant de réparation du monde intérieur :

- conjurer la honte
- contenir la proximité d'autrui
- empêcher la désorganisation du monde vécu
- = c'est un épuisement ontologique latent

7. Synthèse clinique et phénoménologique

- Fatigue physique : atteinte du pouvoir, pas du sens
- Fatigue psychogène : atteinte du sens avant l'atteinte du pouvoir
- Épuisement : sentiment de fin et d'historialité
- Mélancolie : fatigue non au premier plan, mais inhibition du pouvoir-être

Importance clinique et existentielle :

- > Le corps, le sens, le temps et la valeur ne s'épuisent pas de la même manière :
 - évite de confondre des phénomènes différents
 - permet de ne pas médicaliser > travail psychothérapeutique sur le sens et la valeur
 - rappelle le rapport fondamental au monde : effectif et pratique, fondé sur un double originaire : « cela vaut » et « je peux »

II - Phénoménologie du quotidien

1. Introduction

Hypothèse directrice : la souffrance psychique ne se manifeste pas seulement dans des contenus mentaux isolés, mais dans une transformation du rapport ordinaire au monde, le quotidien

Clinique du quotidien :

- être attentif aux gestes les plus ordinaires
- décrire la manière dont le monde est vécu comme familier ou au contraire comme problématique
- et comprendre la souffrance comme une altération de cette familiarité

1.1. Observations cliniques

Patiente de 32 ans

Une patiente de 32 ans consulte pour « fatigue » et « perte d'élan ». Elle travaille, vit en couple, ne présente pas d'antécédents psychiatriques marqués. Elle dit d'emblée : « *Rien de grave... mais tout est devenu difficile.* »

Quand on lui demande de décrire une journée ordinaire, elle répond longuement, avec précision : le réveil sonne, elle l'éteint, reste allongée « *trop longtemps* », se lève finalement « *sans raison* ». Les gestes les plus simples — préparer le café, s'habiller, sortir — lui demandent un effort qu'elle qualifie d'« *incompréhensible* ». Elle dit : « *Je sais ce que j'ai à faire, mais ça ne s'enclenche pas.* »

Au travail, elle accomplit ses tâches, mais de manière mécanique. Elle parle d'un sentiment d'étrangeté : « *Je fais comme si c'était moi, mais je ne suis pas vraiment dedans.* » Les interactions avec ses collègues sont devenues fatigantes ; elle dit devoir « *réfléchir* » à des choses qui allaient de soi auparavant : quand parler, quoi dire, comment se tenir. Elle craint de « *mal faire* » des choses pourtant routinières.

Le soir, chez elle, les objets familiers lui paraissent « *lointains* » ou « *sans intérêt* ». Elle ne trouve plus de plaisir dans ses habitudes — cuisiner, regarder une série, lire. « *Tout est à sa place, mais rien n'a de valeur.* » Elle ne décrit pas de tristesse intense, mais une forme de platitude : « *C'est comme si le monde avait perdu son relief.* »

Par moments, elle éprouve aussi une inquiétude diffuse : elle relit ses mails plusieurs fois avant de les envoyer, doute de ce qu'elle vient de faire. Elle dit : « *Avant, je faisais confiance... maintenant je dois vérifier* » Elle reconnaît que ces vérifications la rassurent un instant, puis le doute revient.

Transformation globale du rapport au monde quotidien :

- les gestes ne vont plus de soi
- le temps s'alourdit
- l'espace familier perd son évidence
- les interactions deviennent problématiques
- la valeur des choses s'éteint
- et une inquiétude diffuse s'insinue dans ce qui était auparavant évident.

Lecture du tableau clinique à trois niveaux :

- *Niveau transcendantal* : vacillement de l'évidence naturelle du monde de la vie
- *Niveau socio-historique* : difficulté à habiter les rôles et les normes
- *Niveau existentiel* : modification d'une certaine manière d'habiter le monde

Processus de quotidianisation fragilisé

Dialectique entre familiarité et étrangeté

Clinique de ce quotidien : reconstruction progressive d'un monde familial

Homme de 28 ans

Un homme de 28 ans consulte pour des difficultés apparues progressivement depuis environ un an. Il travaille, vit seul, et ne rapporte pas d'événement déclencheur précis. Il dit : « *Ce n'est pas une peur en général... c'est surtout dehors.* »

Il explique que certains trajets sont devenus difficiles. Prendre le métro, traverser une place ouverte, entrer dans un magasin bondé : ces situations, auparavant banales, lui demandent désormais une préparation. Il choisit ses horaires, repère les sorties, anticipe des itinéraires alternatifs. Il part plus tôt pour éviter les heures d'affluence, ou renonce à certaines sorties.

Quand il se trouve dans ces lieux, il décrit une tension diffuse, comme si quelque chose pouvait arriver sans qu'il sache quoi. « *Rien de précis... mais je me sens exposé.* » Il surveille son corps, guette des signes de malaise, vérifie qu'il pourra sortir rapidement si nécessaire. Il se place près des portes, évite le centre des espaces, préfère rester en mouvement.

À son domicile, il se sent nettement mieux. Il décrit son appartement comme un lieu « *sûr* », où les gestes se font sans effort et sans inquiétude. Il organise aussi son quotidien autour de quelques lieux familiers (son travail, deux commerces de proximité) et évite les endroits imprévisibles ou trop vastes.

Il reconnaît que ces aménagements restreignent progressivement sa vie : il refuse certaines invitations, décline des déplacements professionnels, et limite ses activités sociales. Il dit : « *Je m'adapte... mais je sens que ça rétrécit mon monde.* » Il ajoute : « *Le plus étrange, c'est que je sais que ces lieux ne sont pas dangereux. Mais ça ne change rien.* »

Lecture du tableau clinique à trois niveaux :

- *Niveau transcendantal* : fragilisation de l'évidence naturelle de la praticabilité du monde
- *Niveau socio-historique* : difficulté à habiter les rôles et les normes ordinaires
- *Niveau existentiel* : modification d'une certaine manière d'habiter le monde

Processus de quotidianisation partiellement défaillant

Accentuation de la tension entre familiarité et étrangeté

Clinique de ce quotidien : restauration progressive d'une spatialité habitable

1.2. Une structure à trois niveaux

Niveau 1 — Transcendantal (Husserl) : le monde de la vie (Lebenswelt)

- sol pré-théorique de toute signification
- évidence naturelle (le monde va de soi)
- intersubjectivité originaire
- horizon de toute expérience possible

Dans la vignette 1, ce niveau se manifeste quand les gestes doivent être "décidés" au lieu d'aller de soi

Dans la vignette 2, quand se déplacer requiert des anticipations et des stratégies au lieu d'une praticabilité immédiate.

Niveau 2 — socio-historique (Schütz, Lefebvre, Bégout)

- pratiques sociales et institutions
- normes et rôles
- organisation du temps et de l'espace
- culture (matérielle et symbolique)

Les deux vignettes montrent aussi le poids des typifications et normes ordinaires :

- la patiente doit expliciter les codes interactionnels
- le patient doit "aménager" sa participation aux espaces publics.

Niveau 3 — Existentiel (Heidegger, Merleau-Ponty, Binswanger)

- manière d'habiter
- rapport au temps et à l'espace
- tonalités affectives
- style d'existence

Au niveau existentiel :

- la patiente décrit une perte d'élan et de valeur du monde
- le patient opère une reconfiguration globale de son monde en zones sûres et zones inquiétantes.

Le quotidien peut ainsi être compris :

- comme *structure transcendantale* (fondement de l'expérience)
- comme *forme de vie* historique (organisation sociale du monde ordinaire)
- comme *modalité existentielle* (manière d'habiter ce monde)

Ces trois niveaux ne s'opposent pas : ils se superposent et permettent de tenir ensemble :

- le fondement de l'expérience
- sa configuration sociale
- sa réalisation vécue

Ils ne sont pas en relation causale mais en *corrélation* : ils décrivent différentes dimensions d'une même transformation du rapport au monde.

La « quotidianisation » est un processus unificateur transversal à ces trois niveaux :

- le quotidien = forme stabilisée et familière du monde vécu
- la quotidianisation = processus dynamique qui produit et maintient cette familiarité

Bégout Bruce, « L'ontologie husserlienne du monde de la vie quotidienne », dans Jocelyn Benoist,

Bruno Karsenti (dir), *Phénoménologie et sociologie*, Paris, PUF, 2001, p. 83-104.

Bégout Bruce, *La découverte du quotidien*, Paris, Allia, 2005.

2. L'énigme du familier

2.1. Le quotidien comme mode de manifestation du monde

Le plus visible est invisible

Les deux vignettes sont précisément intéressantes parce qu'elles rendent visible ce qui d'ordinaire reste invisible :

- la patiente découvre les gestes comme "problèmes"
- le patient découvre l'espace public comme condition à vérifier.

Constats initiaux :

- le quotidien est partout et nulle part
- il est omniprésent et échappe à toute délimitation
- sa richesse empirique rend la conceptualisation difficile

Un mode de manifestation, caractérisé par :

- la répétition temporelle
- la familiarité spatiale
- la proximité pratique

Un monde « pré-donné » :

« Est quotidien tout ce qui, dans notre environnement, nous est immédiatement accessible, compréhensible et familier par sa régularité. » (B. Bégout)

Dans les deux observations, ce mode de manifestation se défait : le monde se donne désormais "avec problème", comme s'il exigeait :

- une validation (vérification chez la patiente)
- un repérage/contrôle chez le patient.

2.2. Le double visage du quotidien

L'idéologie contemporaine de la « valeur refuge »

Une " en-topie " = un refuge du familier :

- sécurité, mais clôture
- tranquillité, mais absence de sens
- confort, mais perte de verticalité

Compréhension commune *erronée* :

- le quotidien est aussi l'expérience de l'étrangeté.
- il naît du processus de familiarisation qui inclut toujours une part d'inconnu.
- il y a une dialectique entre familiarité et inquiétante étrangeté

Dans les observations :

- le patient fabrique un « centre de sécurité » (domicile, trajets connus),
 - la patiente tente de rétablir une sécurité locale par la vérification
- mais ces sécurités restent fragiles et coûteuses.

2.3. Le « Lebenswelt »

Husserl : la matrice phénoménologique du quotidien

La découverte du « monde de la vie » (*Lebenswelt*)

Husserl Edmund, *La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale* (1935-1936), Paris, Gallimard, 2004.

Réflexion épistémologique initiale :

- le monde de la vie est le monde de l'expérience vécue
- il est antérieur à toute objectivation théorique
- il révèle le sol pré-scientifique et pré-conceptuel sur lequel repose tout sens possible.

Les deux cas cliniques peuvent se lire comme des fissures de l'attitude naturelle : ce qui n'avait pas à être justifié ou assuré (agir, se déplacer, interagir) doit désormais être soutenu par des contrôles, des calculs ou des décisions explicites.

La « crise de la science » :

- en se spécialisant, les sciences ont perdu contact avec le monde vécu qu'elles prétendaient décrire
- elles ont substitué à la *richesse qualitative* du monde de la vie une *abstraction mathématique*

La structure du *Lebenswelt* :

- pré-théorique
- intersubjectif
- pratique
- routinier
- évident

Il est le " garant horizontal " de la vérité, la base préconceptuelle de toute rationalité

3. Le quotidien comme « structure de l'expérience »

La familiarité pré-réflexive et l' " évidence naturelle "

Observations : Les vignettes cliniques montrent ce qui se passe lorsque cette transparence se perd :

- la patiente doit thématiser des gestes élémentaires ("effort incompréhensible")
- le patient doit thématiser des conditions spatiales implicites (issues, distances, densité).

Concepts clés :

- Le « monde ambiant », l'*Umwelt* (Heidegger) : un réseau de renvois pratiques

Observations :

- dans la vignette 1, le milieu (*Umwelt*) se dévitalise : les objets sont là mais ne "renvoient" plus à des possibilités engageantes ;
- dans la vignette 2, l'*Umwelt* se fragmente en parcours possibles/impossibles.

- L'« attitude naturelle » (Husserl) : le monde est pré-donné dans une "croyance originaire"

Observations. La perte de cette "croyance" se traduit cliniquement par le besoin :

- de vérifier (vignette 1)
- d'anticiper/contrôler (vignette 2)

ce qui, auparavant, allait de soi.

- *Le « schéma corporel »* (Merleau-Ponty) : connaissance pratique du monde

Observations. Le schéma corporel "ne porte" plus l'action :

- chez la patiente, les gestes perdent leur automaticité motrice
- chez le patient, le corps devient objet de surveillance et guide une spatialité défensive.

- *l'« ontologie du quotidien »* (Bégout)

3.1. Les structures fondamentales du monde quotidien

Trame constitutive de la familiarité :

- le quotidien est une forme d'existence structurée
- cette structure est le résultat d'un processus dynamique

Les structures du quotidien sont spatiales, temporelles et causales :

Les deux cas cliniques permettent d'illustrer immédiatement ces trois dimensions :

- (1) spatialité perturbée surtout chez le patient phobique
- (2) temporalité alourdie surtout chez la patiente
- (3) causalité pratique perturbée dans les deux cas, puisque l'enchaînement ordinaire des actions doit être soutenu (décider/vérifier/anticiper).

- familiarité des lieux
- régularité des rythmes
- enchaînement pratique des actions
- tension permanente entre le familier et l'étranger

Base existentielle du bien-être (*forme affective* de cette adéquation ordinaire) :

- être ajusté au monde
- être inscrit dans une continuité d'évidences qui soutient l'action

3.2. L'équilibre familier / étranger

L'étrangeté inexpugnable : imprévus, anomalies, crises, situations limites...

Le quotidien : un mouvement d'équilibre en tension avec le "réel" (C. Dejours)

Cette tension est « constitutive » :

- sans étrangeté : la familiarité s'éteint
- sans familiarité : la vie devient impossible

Observations. Deux modalités différentes de déséquilibre :

- dans la vignette 1, l'étrangeté envahit le familier (doute, distance, perte de valeur)
- dans la vignette 2, elle se territorialise (zones inquiétantes).

Lieux et temps de la souffrance. Le quotidien devient :

- lourd dans la dépression
- menaçant dans l'angoisse
- étrange dans la psychose, etc.

L'analyse du quotidien doit :

- penser la tension entre le familier et l'étrange
- refuser aussi bien la banalité plate que l'abstraction vide

- adopter une pensée du contraste et de la distance

3.3. La spatialité quotidienne : un espace domestiqué

Une géographie du familier = une structure d'horizon :

- espace proche
- espace ordonné
- espace hiérarchisé, ...

La vignette 2 en donne une illustration directe : le monde se reconfigure en centres de sécurité (domicile, trajets connus) et marges incertaines (métro, place ouverte, foule).

3.4. La temporalité quotidienne : rythme, répétition, routine

Un temps rythmé par :

- les habitudes (sédimentation active de l'expérience)
- les cycles
- les obligations, ...

Des temporalités différentes :

- temps de la nécessité
- temps choisi
- temps flottant, ...

La vignette 1 rend sensible cette modification :

- le matin s'étire ("reste allongée trop longtemps")
- les gestes perdent leur élan
- le présent devient épais, lourd, comme privé de protention.

3.5. La socialité quotidienne

Interactions et rôles

- relations familiales, professionnelles, amicales
- codes sociaux, rituels
- langage ordinaire
- rôles " typifiés "

Observations :

- dans la vignette 1, les typifications interactionnelles se défont : la patiente doit réfléchir à "quand parler, quoi dire"
- dans la vignette 2, les typifications de co-présence dans l'espace public (flux, proximité) deviennent sources de tension.

Mais dans la situation normale : le quotidien est un tissu d'évidences partagées où chacun sait approximativement « comment on fait les choses ».

Schütz Alfred, *Essais sur le monde ordinaire*, Editions du Félin, 2010.

Schütz Alfred, *Éléments de sociologie phénoménologique*, L'Harmattan, Paris, 2014.

Perreau Laurent, " Alfred Schütz et le problème du monde de la vie ", *Philosophie*, n° 108, 2011/1, p. 35-54.

Tellier Frédéric, *Alfred Schütz et le projet d'une sociologie phénoménologique*, Paris, PUF, 2003.

Cette socialité est à la fois intégratrice et contraignante

Normativité : le permis et le possible

Un régime de régularité normative :

- normes pratiques ; comment se conduire
- les normes de métier : comment travailler
- normes morales : quoi faire

La " confiance ontologique " (le " cœur phénoménologique " du " bien-être ") :

- elle ne relève pas d'un jugement
- elle ne se réduit pas au plaisir ou à la satisfaction
- = c'est la consonance silencieuse avec la régularité du monde

Observations. Dans les deux cas, cette confiance est entamée :

- la patiente ne "fait plus confiance" et vérifie
- le patient ne se repose plus sur la praticabilité immédiate et maintient une vigilance constante.

4. Le processus de « quotidianisation »

4.1. La constitution du quotidien

Le quotidien n'est pas un " donné ", mais un " construit "

« Nous nommons quotidianisation ce processus d'aménagement matériel du monde incertain en un milieu fréquentable, ce travail de dépassement de la misère originelle de notre condition par la création de formes de vie familières. » (Bégout, op. cit. p. 225).

La quotidianisation = principe dynamique unificateur entre :

- structure à portée transcendantale (sol de l'expérience)
- forme sociale/historique (vie quotidienne)
- modalité existentielle (manières singulières d'habiter le monde)

La quotidianisation est la domestication progressive de l'étrangeté du monde en familiarité.

4.2. Une « genèse socio-transcendantale » du quotidien

Visée : produire un monde praticable (espace, temps, causalité)

« Le processus de quotidianisation a pour finalité de produire un monde sûr et hospitalier. Il y parvient en modelant l'espace, le temps et la causalité selon les critères de la sécurité et de la familiarité (...) Ni innées ni a priori, ces structures générales du monde quotidien découlent seulement du processus de quotidianisation. Elles représentent son résultat formel. » (Bégout, op. cit., p. 319)

L'habitude, un principe constitutif de la quotidianisation :

" S'il n'y avait pas l'habitude, la vie devrait paraître délicate à des êtres qui seraient à chaque heure menacés de mourir – c'est-à-dire à tous les hommes " (Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, vol. II, p. 73)

« Sans l'habitude, c'est-à-dire la quotidienneté, l'expérience du monde se déroulerait dans une atmosphère ambiguë de découvertes et d'agressions, d'attraction et de répulsion. Comme au premier jour, tout serait incertain, et par cela sans doute excitant et assurément inquiétant. L'illimité gouvernerait toutes choses. » (Bégout, op.

cit., p. 313)

Familiarité et monde ambiant (*Umwelt*) : comment le monde devient habitable :

« c'est cette Vertrautheit, cette familiarité ou cette confiance, qui constitue le phénomène originaire de la quotidienneté. » (F. Dastur, « Heidegger espace, lieu, habitation », Les Temps Modernes, n° 650, 2008/4, p. 142).

Processus dialectique :

« La quotidianisation ne vit que de ce de qui la contrarie. À défaut de pouvoir assimiler les multiples données inconnues qui apparaissent constamment à ses frontières (...), la domestication familière dépérirait en une vie morose, sclérosée, ossifiée, une vie moins qu'ordinaire. » (Bégout, 2005)

Les opérations élémentaires :

- répétition
- domestication
- appropriation
- sédimentation

Ceci autour d'une tension constitutive entre inquiétude et assurance, entre étrangeté et familiarité

5. Clinique du quotidien

5.1. Le monde quotidien comme fond de toute santé psychique

Le « monde de la vie » est la condition de la normalité existentielle = « santé existentielle »

Le *bien-être* est « au-delà de la satisfaction » :

- « monde cohérent » (Minkowski)
- « présence tranquille » (Tatossian)
- « confiance ontologique » (Tellenbach)
- « accord fondamental » avec le monde (Binswanger)
- « ajustement silencieux au champ du possible » (Merleau-Ponty)

Phénoménologie du « bien-être » (traits descriptifs d'un monde qui "tient") :

- fluidité de l'expérience
- présence pleine
- ouverture temporelle
- accordage affectif
- légèreté ontologique
- capacité d'être affecté
- acceptation de l'ambiguïté
- enracinement, etc.

5.2. Les dérèglements de la quotidienneté

Le « dérèglement » est toujours structurellement possible :

- les structures de constitution sont fragiles
- elles sont toujours en tension (valoir/pouvoir, familier/étranger, etc.)
- elles ne sont jamais totalement stabilisées

En substance :

Constitution (transcendantale) : rend possible l'expérience du monde
Quotidianisation : stabilise le monde comme familier et habitable
Psychopathologie : altération de cette constitution (et donc de la quotidianisation)

Schizophrénie : perte de l'évidence et étrangeté du familier

Rupture de la familiarisation du monde :

- difficultés praxiques
- situations sociales énigmatiques
- objets sans évidence pratique

Lien avec la vignette 1 (patiente) : lorsqu'elle dit devoir « réfléchir » à quand parler ou comment se tenir, on voit déjà une micro-désagrégation de cette évidence pratique — sans atteindre la rupture radicale de la psychose.

Dépression : le monde familier sans valeur

Rigidification / appauvrissement du processus :

- les gestes sont accomplis mécaniquement
- les routines continuent mais « à vide »
- le temps se fige et ne porte plus de possibilités

Lien direct avec la vignette 1 (patiente) : « tout est à sa place, mais rien n'a de valeur » — formulation quasi paradigmatique d'une quotidianisation maintenue mais désaffectée, vidée de son sens.

Trouble obsessionnel : hypertrophie et procéduralisation du quotidien

Le trouble obsessionnel révèle paradoxalement la structure du quotidien en l'exagérant :

- fragilisation de l'évidence pratique
- doute existentiel portant sur la fiabilité de l'action et du monde
- procéduralisation de l'agir
- rigidification temporelle
- altération de l'initiative motrice

Observations :

Lien avec la vignette 1 (patiente) : les relectures répétées des mails et le besoin de « vérifier » indiquent une fragilisation de l'évidence pratique : ce qui allait de soi (avoir « bien fait », avoir écrit correctement) ne se stabilise plus dans une certitude tacite. La vérification fonctionne alors comme procédure de suppléance, destinée à produire artificiellement une assurance que l'habitude ne fournit plus. Le quotidien ne porte plus l'action de manière fluide : il faut la sécuriser par une suite d'opérations réflexives (relire, contrôler, recommencer), qui rigidifient le cours ordinaire des gestes.

Lien (plus indirect) avec la vignette 2 (homme de 28 ans) : le repérage systématique des sorties, la planification d'itinéraires alternatifs et la "mise en sécurité" des trajets relèvent aussi d'une procéduralisation défensive du quotidien. Ce n'est pas un rituel obsessionnel au sens strict, mais une façon de compenser la perte de confiance dans l'évidence spatiale en multipliant des gestes de contrôle.

Anxiété : quotidien sous menace

La quotidianisation fonctionne encore, mais elle est surchargée de vigilance :

- le monde est pénétré par l'étrangeté
- les situations ordinaires doivent être anticipées, sécurisées, contrôlées,
- le sujet ne peut plus se reposer sur l'évidence des choses,
- le moindre imprévu devient une menace possible.
- la vigilance envahit l'expérience, etc.

Lien avec la vignette 2 (homme de 28 ans) : choix des horaires, repérage des sorties, position près des portes : autant de stratégies visant à re-fabriquer artificiellement la familiarité perdue.

Addiction : rigidification artificielle du familier

Le sujet tente de recréer artificiellement une familiarité qui fait défaut :

- répétition ritualisée des prises ou des conduites
- organisation du quotidien autour de la substance ou du comportement
- réduction du champ d'expérience à un milieu restreint mais contrôlable

Observations :

Lien indirect avec le patient : fragilisation de la familiarité spatiale et envahissement par l'étrangeté

5.3. Le soin comme « re-quotidianisation »

Clinique de l'ordinaire :

- attentive aux gestes, aux rythmes, aux lieux, aux interactions
- vise une restauration progressive de la confiance tacite qui soutient l'existence

Leviers possibles :

- Rythmes et temporalité :
 - restaurer une continuité des jours (sommeil, repas, régularités minimales),
 - réintroduire un avenir proche praticable (micro-projets, séquences d'action simples).
- Repères spatiaux et habitabilité :
 - stabiliser un cadre (lieux, trajets, points d'ancrage),
 - rendre certains espaces à nouveau fréquentables, sans surcharger l'expérience de stratégies défensives.
- Monde commun et intersubjectivité :
 - soutenir le « monde à deux » de la rencontre,
 - restaurer des évidences partagées (par la co-présence, le langage ordinaire, des rituels de parole).

> Le « *travail du monde* » (Tatossian) : rétablir un horizon commun

Exemples (très schématiques) :

- dans la schizophrénie : soutenir les repères spatio-temporels, les continuités minimales, la protection contre l'hyper-réflexivité
- dans la dépression : réintroduire de petites régularités qui redonnent prise et valeur au monde
- dans l'anxiété : stabiliser le cadre, diminuer la surcharge de vigilance, élargir progressivement la zone du familier.

III - Phénoménologie de l'habiter

« Regarder un objet, c'est venir l'habiter » (M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 82)

1. Introduction

Cette troisième partie prolonge l'analyse de la quotidienneté en l'ancrant dans sa dimension spatiale et corporelle.

Elle propose d'aborder l'habiter comme une structure existentielle de l'être-au-monde, à partir de laquelle un monde se déploie comme lieu "praticable", orienté et affectivement qualifié.

1.1. Observations cliniques

Madame L., 38 ans

Madame L., 38 ans, est reçue en consultation à la suite d'un déménagement récent. Elle dit « ne pas réussir à se sentir chez elle » dans son nouvel appartement, bien que celui-ci soit confortable et correctement aménagé. Dès les premières séances, elle décrit une impression diffuse de ne pas pouvoir « se poser ». Elle passe beaucoup de temps à circuler d'une pièce à l'autre, sans parvenir à s'installer durablement dans un espace. Elle explique qu'elle change régulièrement la disposition des meubles, sans que cela améliore son sentiment.

Lorsqu'elle parle de son ancien logement, elle évoque spontanément des lieux précis : la cuisine « où tout était à portée de main », la fenêtre du salon « d'où elle regardait la rue », le trajet quotidien vers son travail. Dans son nouvel environnement, elle dit ne pas avoir encore « ses repères » et se perdre parfois dans des gestes simples, comme chercher un objet ou retrouver un interrupteur dans l'obscurité.

Elle décrit également un malaise diffus dans certaines pièces, en particulier dans le couloir et la chambre, qu'elle qualifie de « froids » et « sans vie ». À l'inverse, elle passe plus volontiers du temps dans la cuisine, qu'elle a investie en premier lieu. Elle précise qu'elle laisse souvent la porte d'entrée entrebâillée lorsqu'elle est seule, disant qu'elle « a besoin de sentir qu'elle peut sortir facilement ».

Sur le plan relationnel, elle mentionne des tensions avec son conjoint depuis le déménagement, notamment autour de l'usage des espaces communs. Elle dit avoir du mal à « trouver sa place » dans l'appartement, et se réfugie fréquemment dans la salle de bain pour s'isoler.

Elle rapporte enfin qu'elle sort moins qu'auparavant, limitant ses déplacements aux trajets strictement nécessaires. Elle dit que le quartier lui paraît « impersonnel » et qu'elle ne sait pas encore « où aller » pour se promener. Elle ajoute : « Avant, j'avais mes endroits. Là, je suis un peu comme suspendue. »

Commentaire clinique. L'« habiter » engage :

- une manière de déployer un monde à partir d'un ancrage corporel
- des habitudes pré-réflexives, dans la familiarité des gestes et des trajets
- les tonalités affectives et les atmosphères

- une dimension intersubjective (tensions dans le couple et difficulté à « trouver sa place »)
- certaines figures existentielles : s'installer, circuler, se retirer, explorer, ...

Monsieur R., 52 ans, éleveur bovin

Monsieur R., 52 ans, est éleveur bovin depuis plus de vingt-cinq ans. Il vit sur l'exploitation familiale qu'il a reprise à la suite de son père. Depuis deux ans, il décrit une dégradation progressive de sa situation, marquée par des difficultés économiques, des tensions administratives, et une séparation récente avec sa conjointe.

Lorsqu'il parle de sa ferme, il utilise des expressions inhabituelles pour lui : il dit qu'« il ne reconnaît plus les lieux », que « tout est devenu lourd ». Il évoque une impression persistante de ne plus être « chez lui » sur l'exploitation, alors même qu'il n'a pas changé de lieu de vie.

Dans son travail quotidien, il décrit une perte de familiarité avec les gestes les plus ordinaires. Il dit avoir besoin de réfléchir à des actions qu'il effectuait auparavant « sans y penser », comme l'organisation de la traite, la préparation de la ration ou la gestion des clôtures. Il oublie des étapes, se trompe dans les parcours des animaux, et dit parfois « tourner en rond dans la cour ».

Sa relation aux animaux s'est également modifiée. Il explique qu'il avait auparavant le sentiment de « connaître ses bêtes », de reconnaître leur comportement, leur état, leurs habitudes. Désormais, il dit ne plus « les sentir », ne plus parvenir à anticiper leurs réactions. Il se tient davantage à distance et limite les contacts. Certaines tâches lui paraissent devenues dangereuses, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant.

Il évoque un sentiment de malaise dans certains espaces de la ferme, notamment dans le bâtiment d'élevage et dans le hangar. Il dit s'y sentir « oppressé » et évite d'y rester plus longtemps que nécessaire. À l'inverse, il passe davantage de temps dans la maison, où il dit « se replier ».

Le territoire environnant, qu'il connaissait très bien, lui apparaît désormais « étranger ». Il sort moins, ne participe plus aux réunions professionnelles locales et a cessé de fréquenter les exploitations voisines. Il dit qu'il « n'a plus sa place » dans ce milieu.

Il décrit enfin une fatigue importante et un sentiment d'échec, avec l'impression que « tout se délite » : le travail, la ferme, les relations.

Commentaire clinique. Les difficultés portent sur :

- une désorganisation de son rapport spatial, corporel et pratique à l'environnement
- rôle des possibilités pratiques du milieu
- l'importance des atmosphères et des tonalités affectives
- altération des figures existentielles : circuler, explorer, s'inscrire dans un territoire élargi
- dimension intersubjective et territoriale de l'habiter (idem que précédemment)

En résumé, la situation peut être comprise comme :

- une désorganisation de la territorialisation
- avec perte de repères, de centres, de frontières et de pratiques stabilisées
- affectant à la fois le rapport au corps, au travail, aux lieux et aux autres.

Ouvertures théoriques :

- le corps et ses capacités
- l'espace vécu et ses repères

- les tonalités affectives
- les pratiques quotidiennes
- les relations intersubjectives
- et les processus de territorialisation et de déterritorialisation,

1.2. Une structure existentielle

Concept d'« Habiter »

- ce n'est pas une condition transcendantale au sens husserlien
- > mais une condition existentielle : la manière originaire dont une existence ouvre un monde et le fait apparaître comme lieu

Les modalités de l'habiter peuvent varier fortement selon les cultures, les individus, les situations, les pathologies....

1.3. Les différentes origines de la réflexion

Heidegger : « Bâtir Habiter Penser »

Exister, c'est " habiter le monde "

Heidegger Martin, « Bauen Wohnen Denken » [1951], *Gesamtausgabe, I Abteilung : Veröffentlichte Schriften 1910- 1976, Band 7 : Vorträge und Aufsätze*, Frankfurt/Main, Vittorio Klostermann, 2000, p. 145-164.

Heidegger Martin, « Bâtir habiter penser », *Essais et conférences*, Paris, Gallimard, coll. "Tel", 2001, p. 170-193.

Bachelard : la « Poétique de l'espace »

Bachelard Gaston, *La poétique de l'espace* [1957], Paris, PUF, 1961

- la maison comme cosmos premier
- la " topophilie "
- la dialectique du dedans et du dehors
- la verticalité de la maison : une " architecture psychique " :

Bollnow : « L'homme et l'espace »

Bollnow Otto Friedrich, *Mensch und Raum. Schriften Band VI* [1963], Würzburg, Königshausen & Neumann, 2011 ; trad. anglaise : *Human Space*, London, Hyphen Press, 2011.

- l'espace " hodologique "
- l'organisation centres/périphéries
- les humeurs spatiales

Merleau-Ponty : la « chair du monde »

Merleau-Ponty Maurice, *Le Visible et l'invisible* [1964], Paris, Gallimard, coll. "Tel", 1979.

- la réversibilité corps-monde
- le lieu comme "style"

Hoyaux « géographie et phénoménologie »

Hoyaux André-Frédéric, « Géographie et phénoménologie : perspectives théoriques et méthodologiques autour de la proximité et de l'authenticité », dans Bruno Frère, Sébastien Laoureux (dir.), *La phénoménologie à l'épreuve des sciences humaines*, P.I.E. Peter Lang, p. 73-88, 2013.

Hoyaux André-Frédéric, « Entre construction territoriale et constitution ontologique de l'habitant : Introduction épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d'habiter », *Cybergeog* :

European Journal of Geography [En ligne], *Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, Document* 216.

Hoyaux André-Frédéric, « Habiter : se placer plaçant et se penser pensant », *Annales de géographie*, 2015/4, n° 704, p. 366-384.

Hoyaux André-Frédéric, « Corps en place, place du corps », *L'Information géographique*, 2016/2, vol. 80, n° 2, p. 11-31.

2. L'habiter comme structure existentielle

2.1. L'habiter comme mode d'être

Habiter : déployer un monde à partir d'un ancrage

> une structure fondamentale du Dasein qui engage :

- le corps
- le monde
- le sens

"Etre-dans" un monde = habiter ce monde

On retrouve cela chez Mme L., qui occupe matériellement son appartement mais ne parvient pas à s'y engager comme dans un monde habitable.

2.2. La structure tripolaire de l'habiter

- ancrage corporel

Chez M. R., cette dimension se fragilise lorsque les gestes professionnels autrefois incorporés deviennent hésitants et réfléchis.

- déploiement spatial

Mme L. illustre cette désorganisation lorsqu'elle ne parvient plus à retrouver ses repères spatiaux les plus simples dans son logement.

- tonalité affective

Certaines pièces apparaissent à Mme L. comme « froides » ou « sans vie », montrant la tonalité affective de l'espace.

L'espace vécu et la notion de " milieu " (*Umwelt*)

La « distance existentielle »

Le corps comme condition existentielle

Habiter suppose un "je peux" spatial

Habiter un lieu et habiter son corps forment une continuité phénoménologique (Merleau-Ponty) :

- le lieu est incorporé
- le schéma corporel s'étend à l'espace
- le savoir-faire spatial est pré-réflexif (trouver son chemin, agir dans le noir)

> Continuité phénoménologique entre " habiter un lieu " et " habiter son corps "

Seuils et frontières

Les seuils sont des " opérateurs existentiels " :

Le fait que Mme L. laisse la porte d'entrée entrouverte illustre l'effacement de la frontière entre dedans et dehors

- . entre le dedans et le dehors
- . entre le privé et le public
- . entre l'intime et l'exposé, etc.

Fonctions des frontières :

- . protection / exposition
- . intimité / visibilité
- . continuité / rupture, etc.

> Le " chez-soi " est un " centre existentiel "

2.3. L'habiter comme processus temporel de familiarisation

Processus temporel de l'habiter :

L'expérience de Mme L. montre précisément ce moment intermédiaire où la familiarisation n'est pas encore stabilisée.

Chez M. R., on observe au contraire une perte secondaire de cette familiarisation pourtant ancienne.

- découverte
- exploration
- familiarisation
- appropriation, etc.

Le quotidien est une « rythmique de l'habitation » :

- micro-rituels
- trajets récurrents
- allers-retours répétés, etc.

+ maintien d'une part d'étrangeté : le familier n'épuise jamais totalement le lieu

Atmosphères et dimension pathique de l'espace

Les lieux nous affectent avant d'être pensés :

- accueillants ou hostiles
- légers ou lourds
- ouverts ou fermés, etc.

L'habiter est un accordage affectif au milieu, une tonalité globale :

- sécurité
- confiance
- inquiétude
- malaise, etc.

Le sentiment d'oppression dans certains bâtiments chez M. R. en constitue un exemple clinique.

Dimensions intersubjectives de l'habiter

Habiter est toujours déjà co-habiter :

- famille
- couple
- colocation
- résidents, etc.

Les tensions conjugales de Mme L. autour de l'usage des espaces communs en illustrent la dimension intersubjective.

> L' « hospitalité » devient une structure centrale

2.4. Figures existentielles de l'habiter

- s'installer
- circuler
- se retirer / se protéger
- accueillir : hospitalité, intersubjectivité.
- explorer, etc.

Observations :

- s'installer → Mme L. ne parvient pas à « se poser »
- circuler → M. R. « tourne en rond dans la cour »
- se retirer → Mme L. se réfugie dans la salle de bain
- explorer → Mme L. ne sort plus dans le quartier

2.5. Habiter, quotidien et bien-être

Georges Perec, *Espèces d'espaces*, Paris, Galilée, 1974 (coll. L'Espace critique)

Georges Perec, *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien [1975]*. Paris : Christian Bourgois, 1982.

Georges Perec, *Lieux*, Paris, Seuil, 2022 (posthume)

Habiter comme condition du quotidien :

- inscription des routines dans l'espace domestique ou professionnel
- soutien de la répétition et de la continuité

Habiter comme condition (existentielle) du bien-être :

- « Être bien » suppose « être quelque part »
- la stabilité spatiale soutient la sécurité ontologique

Le mal-être comme crise de l'habitation :

- une déstructuration du « chez-soi »
- un sentiment d'étrangeté dans le familial
- une errance, etc.

L'habiter est une *structure existentielle* car il organise conjointement :

- la spatialité : un monde praticable
- l'affectivité : les *Stimmungen*, ambiances et atmosphères
- l'identité : le "chez-soi", les appartenances
- la normativité : le possible/impossible, le licite/interdit

3. Psychopathologie de l'habiter

Ludwig Binswanger, *Le problème de l'espace en psychopathologie*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998.

3.1. L'agoraphobie : rupture de la familiarité spatiale

- perte du sol porteur
- dimension corporelle
- espace sans limites
- dépendance à l'objet/personne contraphobique
- spatialité rétrécie, ...

Le rétrécissement progressif du monde habitable évoque, de façon atténuée, la réduction du territoire observée chez Mme L.

3.2. La claustrophobie : enfermement spatial

- oppression par l'espace
- panique du sans-issue
- enserrement du corps propre, ...

3.3. La dépression : délabrement de l'espace habité

- aplatissement spatial
- perte de la dimension de hauteur
- le monde devient un fardeau
- « déshabitation », ...

On retrouve une forme atténuée de cette déshabitation dans le vécu de M. R., lorsque les lieux de travail deviennent inhabités affectivement.

3.4. La schizophrénie : désarticulation de l'espace vécu

- perte de la cohérence spatiale
- troubles de la proxémique
- expériences spatiales étranges
- impossibilité de s'installer, ...

3.5. L'addiction : rétrécissement de l'espace vital

- spatialité organisée par la substance
- perte de la dimension d'altérité
- enfermement, ...

3.6. Le traumatisme : hantise des lieux

- impossibilité d'accès
- intrusions spatiales
- perte de l'habitation sécurisante, ...

4. Le « Soi territorial » et l'habitation du corps

(Se) territorialiser :

- produire un territoire, un lieu
- + se produire soi-même
- > référence au concept de "constitution" (sujet/objet transcendantal)
- + mobilisation des notions de Moi et de Soi

Distinctions opératoires :

- lieu : ce qui est localisable
- milieu : ce qui est praticable
- territoire : ce qui est approprié, signifiant, marqué, défendu, etc.

Gilles Deleuze, Félix Guattari, *Capitalisme et schizophrénie*, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980.

4.1. Genèse du territoire : du corps au monde

Le *corps propre* est le territoire originaire.

La première territorialisation est le " schéma corporel ", permettant les articulations structurantes fondamentales :

- l'ici et le là-bas
- le dedans et le dehors
- le proche et lointain

- le possible et l'impossible, etc.

Les frontières corporelles. Cf. D. Anzieu, *Le Moi-peau* :

- la peau comme limite et interface
- la porosité et étanchéité du corps vécu

Les atteintes aux frontières corporelles (trauma, violence, maladie, vieillissement) = désappropriations corporelles :

- corps familial
- corps étranger
- corps objectivé, etc.

Chez M. R., la perte de familiarité avec les gestes professionnels traduit une altération de ce premier territoire corporel

4.2. Les strates de territorialisation : du corps à l'espace habité

- la *territorialisation primaire* (zones de sécurité/de menace...)
- le *péricorporel* (sphère de l'intime, vêtements, objets portés...)

Mme L. modifie sans cesse la disposition des objets, comme pour tenter de stabiliser son espace péricorporel.

- l'*espace domestique* (le "chez-soi" qu'on appelle "mon intérieur")

Le fait que Mme L. investisse prioritairement la cuisine montre la constitution progressive de micro-territoires habitables.

- les *micro-territoires* ("ma place", "mon coin"...)
- les *territoires élargis* (quartier, chemins, lieux culturels, conviviaux...)

La difficulté de Mme L. à circuler dans le quartier illustre les difficultés d'accès au territoire élargi.

4.3. Le « Soi territorial »

Définition phénoménologique : Le Soi territorial désigne la forme de soi produite par l'appropriation spatiale. L'identité n'est pas seulement psychique ou narrative : elle est aussi « topologique »

Chez Mme L. comme chez M. R., c'est l'ensemble du "Soi territorial" qui se trouve mis en cause : la place dans l'espace devient incertaine, et avec elle la place dans le monde.

En substance : Le Soi territorial peut être défini comme la forme de soi produite et maintenue par l'appropriation spatiale, assurant une continuité d'existence, une stabilité et une inscription située dans le monde.

4.4. Les pratiques quotidiennes de territorialisation

- par le geste
- par les objets
- par la répétition
- par les seuils
- par le langage

> le quotidien est une " sédimentation territoriale "

Les gestes quotidiens (ranger, aménager, circuler) apparaissent chez Mme L. comme des tentatives de re-territorialisation.

4.5. Territorialisation et déterritorialisation

Le territoire comme soutien de la sécurité ontologique et existentielle

La déterritorialisation (précarité résidentielle, hospitalisation, exil, migration...)

Les situations de Mme L. (déménagement) et de M. R. (crise professionnelle et conjugale) peuvent être comprises comme des expériences de déterritorialisation partielle.

4.6. Implications thérapeutiques et professionnelles

Accompagnement, thérapie > " re-territorialisation "

- refaire des centres, des seuils, des périmètres
- reconstruire des micro-territoires, etc.

Travail clinique : accompagner une reterritorialisation progressive, comme par exemple aider Mme L. à stabiliser des repères domestiques ou soutenir M. R. dans la réappropriation de son espace de travail.

(Synthèse) Mr R. Analyse phénoménologique

1. Problème central : une crise de l'habiter (vs "stress" de situation)

Monsieur R. ne décrit pas seulement une difficulté économique ou un surcroît de charge : il dit « ne plus reconnaître les lieux », « tout est devenu lourd », ne plus être chez lui alors qu'il n'a pas déménagé.

Phénoménologiquement, cela indique une « désorganisation de l'habiter » : le monde familial (la ferme comme milieu) ne "porte" plus son existence de manière évidente, praticable et affectivement accordée.

On peut lire ce cas comme une « dé-habitation » progressive : il occupe encore l'espace, mais l'espace ne fonctionne plus comme monde habitable.

2. La structure tripolaire de l'habiter est atteinte (III, 2.2)

2.1. Atteinte du pôle 1 : l'ancrage corporel

L'éleveur dit devoir réfléchir à des gestes auparavant incorporés ("sans y penser"), il oublie des étapes, il se trompe dans les parcours, il "tourne en rond".

Cela indique une « désincorporation » : ce qui était inscrit dans le corps comme savoir-faire pré-réflexif ("schéma corporel professionnel") redevient opération mentale, donc coûteux, fragile et discontinu.

> le corps n'est plus un « véhicule silencieux » de l'action ; il devient un corps problématique, moins fiable, moins orientant.

2.2. Atteinte du pôle 2 : le déploiement spatial (espace vécu)

Le lieu de travail ne se donne plus comme réseau de trajets évidents et de repères stables : il se trompe, il hésite, il se perd dans des enchaînements connus.

C'est une altération de l'espace vécu hodologique (les chemins, passages, circuits) : le monde n'est plus structuré par des parcours fluides, mais par des ruptures, des "blancs", des retours inutiles.

L'espace perd aussi sa hiérarchie : ce qui était "central" (bâtiments d'élevage, hangar) devient difficile, et la maison devient lieu de repli.

> Le monde se reconfigure en zones : zones lourdes/oppressantes vs zone refuge.

2.3. Atteinte du pôle 3 : la tonalité affective (atmosphères)

Monsieur R. parle de lieux devenus "lourds", de bâtiments "oppressants", et il évite certains espaces.

Ici, la pathologie ne tient pas d'abord à des objets, mais à des atmosphères : le lieu est affectivement qualifié avant toute réflexion, et certaines zones cessent d'être "tenables".

> le milieu n'est pas seulement "fonctionnel", il est pathique (accueillant/hostile, ouvert/fermé, léger/lourd). Chez lui, cette tonalité bascule vers l'hostilité et l'oppression.

3. L'habiter comme processus temporel : perte secondaire de familiarisation (III, 2.3)

Il ne s'agit pas d'une familiarisation inachevée (comme Mme L. après déménagement), mais d'une dé-familiarisation d'un monde ancien : une familiarité acquise depuis des décennies se défait.

On peut le décrire comme :

- dé-sédimentation des habitudes (l'habitude ne soutient plus),
 - rupture de la continuité des jours ("ça ne va plus de soi"),
 - et surtout perte de la "réserve de monde" : le lieu ne promet plus des possibles stables.
- > ce n'est pas seulement l'action qui se dérègle, c'est la capacité du monde à soutenir l'action.

4. Les possibilités pour l'action disparaissent : le milieu professionnel perd sa lisibilité

Il dit ne plus "sentir" ses bêtes, ne plus anticiper leurs réactions, certaines tâches deviennent "dangereuses". Les animaux n'apparaissent plus comme "partenaires" de travail lisibles et anticipables, mais comme présences incertaines.

Phénoménologiquement, c'est une perte des prises offertes par le milieu (affordances) : le monde ne se donne plus comme "manipulable" et "prévisible", mais comme potentiellement menaçant.

Ce glissement suffit à transformer tout le rapport au travail : même sans danger objectif accru, le monde devient moins praticable.

5. Figures existentielles de l'habiter (III, 2.4) : rigidification et effondrement partiel

On peut relire ses symptômes avec les figures existentielles mentionnées dans le cm :

- *Circuler* : "tourner en rond", se tromper de parcours > circulation sans orientation, monde moins "connecté".
 - *S'installer* : difficulté à tenir dans le travail, retrait vers la maison > incapacité à "se tenir" dans le lieu professionnel.
 - *Se retirer / se protéger* : repli à la maison, réduction des sorties > refuge défensif.
 - *Explorer* : il sort moins, cesse les réunions, ne fréquente plus les voisins > perte du territoire élargi, fermeture du monde.
 - *Accueillir / cohabiter* : la séparation conjugale et l'isolement social indiquent un affaiblissement du monde partagé (l'habiter est toujours déjà "co-habiter").
- > la crise est dans une dynamique d'existence qui se contracte (moins d'exploration, plus de retrait).

6. Territorialisation / déterritorialisation : atteinte du "Soi territorial" (III, 4)

6.1. Déterritorialisation sans déménagement

Il reste au même endroit mais dit ne plus être chez lui : c'est typique d'une déterritorialisation non géographique.

Les repères, centres, frontières et pratiques stabilisées se défont : il y a perte du "territoire vécu".

6.2. Atteinte des strates de territorialisation (du corps au monde)

Territoire corporel : gestes non incorporés > première strate atteinte (le corps comme base du monde).

Territoire domestique : la maison devient refuge, mais potentiellement au prix d'un rétrécissement (centre défensif).

Territoire professionnel : les bâtiments deviennent évités/oppresseurs > effondrement du territoire de travail.

Territoire élargi : retrait des réseaux locaux, sorties diminuées > contraction du monde social

6.3. Le Soi territorial fragilisé

L'identité n'est pas seulement narrative/sociale, elle est aussi topologique ("je suis aussi là où je tiens").

Chez Monsieur R., "ne plus avoir sa place" dans le milieu agricole, ne plus reconnaître la ferme, c'est une atteinte ipséique : le soi perd sa stabilité située.

- > La crise économique + administrative + conjugale agit comme facteur de déterritorialisation : elle attaque les centres existentiels (travail/maison/collectif), donc la continuité du soi.

7. Seuils et frontières : indices cliniques à expliciter

Même si cette vignette est moins explicite que celle de Mme L., on peut lire :

- le bâtiment d'élevage et le hangar comme des zones "à seuil" (on y entre, mais on n'y tient pas)
- la maison comme seuil protecteur qui se rigidifie en frontière défensive
- le dehors social (réunions, voisins) comme espace devenu "trop exposant", d'où retrait
- > les frontières (protection/exposition) se reconfigurent dans la souffrance

8. Hypothèse synthétique

Chez Monsieur R., la souffrance prend la forme d'une dé-familiarisation et d'une déterritorialisation du monde professionnel et social : l'habiter se désaccorde (corps, espace, atmosphère), le territoire se contracte, et le soi perd sa stabilité située.

9. Ouverture clinique : "reterritorialisation" concrète (III, 4.6)

Axes phénoménologiquement cohérents :

Reconstituer des micro-évidences pratiques (reterritorialisation corporelle)

- reprendre certains gestes en séquences courtes, stables, répétées ;
- restaurer l'incorporation (moins de contrôle mental, plus de routine guidée).

Réhabiter l'espace de travail par zones (reterritorialisation spatiale) :

- distinguer zones tenables / difficiles ;
- réinvestissement progressif (temps courts, repères fixes), pour que l'espace redevienne praticable.

Travailler les atmosphères :

- identifier où ça oppresse / où ça tient
- modifier des conditions concrètes (lumière, organisation, rythme de présence) comme "leviers" d'accordage affectif

Réouvrir le territoire élargi (contre le rétrécissement) : réintroduire un lien local minimal (un voisin, une réunion courte, un trajet, CUMA, coopérative ...), pour que le monde redevienne partagé.

Dimension intersubjective : la séparation n'est pas qu'un "événement", elle modifie le co-habiter : soutenir un minimum de monde commun (alliés, collègues, réseau).

10. Ne pas confondre les perspectives psychothérapeutiques

Dimension	Approche TCC	Approche phénoménologique/existentielle
<i>Cadre général</i>	Modèle fonctionnel, empirique, orienté vers l'efficacité	Modèle phénoménologique, existentiel, orienté vers le sens du vécu
<i>Objet principal</i>	Comportements, cognitions, émotions observables et modifiables	Rapport au monde, structures du vécu, mode d'être-au-monde
<i>Compréhension du trouble</i>	Dysfonctionnements cognitifs et comportementaux	Altération des structures de constitution du monde vécu
<i>Niveau d'analyse</i>	Fonctionnel et opératoire	Structural, phénoménologique et existentiel
<i>Question centrale</i>	« Comment modifier ce qui dysfonctionne ? »	« Comment le monde apparaît-il et se transforme-t-il pour le sujet ? »
<i>Statut du symptôme</i>	Signe d'un dysfonctionnement à réduire ou corriger	Expression d'une modification du rapport au monde, porte d'accès au vécu du sujet
<i>Visée thérapeutique</i>	Réduction des symptômes, amélioration du fonctionnement	Restauration d'un monde praticable, habitable et partageable
<i>Temporalité</i>	Travail sur les anticipations, ruminations, conditionnements	Restauration de la continuité temporelle et de l'ouverture du futur
<i>Espace et environnement</i>	Lieux = situations à affronter ou éviter (exposition)	Espaces vécus = milieux à ré-habiter progressivement
<i>Rythmes et routines</i>	Outils de régulation comportementale	Structures fondamentales de l'existence quotidienne
<i>Rapport à l'action</i>	Modifier les comportements « inadaptés »	Restaurer la spontanéité et l'évidence de l'agir
<i>Relation thérapeutique</i>	Alliance thérapeutique comme support technique	Co-constitution d'un monde commun, « travail du monde »
<i>Langage thérapeutique</i>	Psychoéducation, restructuration cognitive	Mise en mots du vécu, partage d'évidences, co-présence
<i>Conception de la santé</i>	Fonctionnement adapté, réduction des symptômes	Intégrité de la quotidienneté et cohérence du monde vécu
<i>Formulation synthétique</i>	Modifier ce que le sujet fait et pense	Restaurer la manière dont le monde se donne à lui

IV - Phénoménologie des névroses : « l'être en deçà de soi » (phobie, hystérie)

Analyse de l'espace-temps vécu :

- préalable indépendant des thèmes psychologiques
- = problématique de la distance à soi et à autrui (dans un espace non métrique)

Dans la verticalité :

- l'être-au-dessus-de-soi (la présomption)
- l'être-au-dessous-de-soi/des autres (la sensibilité)

Dans l'horizontalité :

- l' "être-en-arrière-de-soi" : situation existentielle du déprimé mélancolique
- l' "être-en-avant-de-soi" : expérience maniaque
- l' "être-en-deçà-de-soi" : situation anthropologique du phobique (inhibition, introversion)
- l' "être-au-deçà-de-soi" : expérience de monde hystérique (dépassement, excès)

1. La spatialité vécue. Espace empirique et espace vécu

1.1. Niveau anthropologique et niveau psychologique

Perspective anthropologique :

- l'espace vécu avant tout contenu
- une pure "situation", dans laquelle on se trouve (entièrement ou partiellement)

*« Le niveau anthropologique met à jour l'expérience de l'homme comme un mouvement permanent de retotalisation et redéfinition situationnelle de soi au regard de ce "tout". S'il est ce "tout" au sens de l'être au monde, c'est-à-dire si son être est en conscience ultime de ce tout, il n'y a rien à dire d'anthropologique ; alors nous "sommes au monde", selon la célèbre formule . S'il n'est pas ce "tout" (le verbe être est alors chargé d'un sens ontologique et situationnel), nous sommes dans un "blocage" situationnel de la résolution dans le "tout". Il en résulte alors une position identifiable en un lieu, bloquée, contrainte, retenue dans une configuration. » (G. Charbonneau, « L'être en deçà de soi ou la hantise de l'outrepassement », dans J. Chamond, *Les directions de sens. Phénoménologie et psychopathologie de l'espace vécu*, Le Cercle Herméneutique, 2005).*

= deux possibilités anthropologiques fondamentales

- a) L'humain est "ce tout" : l'être-au-monde fluide, non problématique
- b) L'homme n'est plus ce "tout" : situation de rupture, blocage, pathologie

Sens de la pathologie en phénoménologie : la souffrance psychique profonde est vécue comme une impossibilité d'habiter pleinement son existence

Notion de « *direction de sens* » = autre formulation (Binswanger) pour désigner une position de "blocage situationnel"

Le phobique est hanté par l'éloignement du proche :

- > la perspective anthropologique met en représentation (spatiale) le champ du possible
- > la spatialité vécue est la relation du soi à soi dans sa structure de possibilité

Dans le cas phobique : un permanent retour *en deçà*

L'espace : le lieu d'expression de la présence humaine dans sa structure globale

Synthèse (tableau) :

- niveau anthropologique : structure fondamentale

- niveau empirique/psychologique : contenus et formes symptomatiques concrètes

Dimension	Niveau anthropo-phénoménologique	Niveau empirique / psychologique (clinique descriptive)
Définition	Expérience fondamentale de l'espace vécu, avant tout contenu psychologique ou biographique.	Manifestation concrète et symptomatique dans la vie psychique du sujet (avec contenus affectifs, cognitifs, biographiques).
Objet d'analyse	La situation existentielle (l'« être-au ») : position structurelle du sujet par rapport au monde (ex. : en-deçà de soi, en arrière de soi, etc.).	Les symptômes observables ou décrits : agoraphobie, claustrophobie, nosophobie, phobie sociale, etc.
Rapport à l'espace	Espace non métrique : vécu de proximité / distance à autrui, expérience de limites, de bords, de centralité.	Espace empirique : lieux concrets déclencheurs de symptômes (ponts, places, foules, pièces fermées, hôpitaux...).
Temporalité associée	Structure du possible : ouverture ou blocage des potentialités existentielles.	Temporalité vécue concrète : anticipations anxieuses, crises ponctuelles, souvenirs traumatiques.
Exemple phobique	"Être en-deçà de soi" : retrait existentiel, hantise de l'outrepassement, impossibilité de se déployer.	Agoraphobie : peur d'être « au milieu », loin du bord ; claustrophobie : peur d'être enfermé sans sortie ; nosophobie : peur d'une maladie menaçante.
Statut épistémologique	Niveau autonome, relativement indépendant des contenus psychologiques (structure du rapport au monde).	Niveau thématique, lié à l'histoire et aux représentations singulières du sujet (contenu biographique, objets phobogènes).

Exemple clinique : nosophobie à structure spatiale (non métrique)

Léa, 35 ans, ingénieure. Collègue hospitalisé pour une infection « rare ». Depuis, Léa évite les hôpitaux et les infos santé.

Installation en 3 semaines : Après un reportage TV, elle repère une petite plaque rouge sur le ventre. Déclenche une angoisse aiguë : « *C'est au centre de moi... si je m'en éloigne, je me perds.* »

Propos et vécus rapportés :

- sensation d'être aspirée par le « centre » (la plaque)
- vérifications répétées au miroir
- crainte du "trop loin" : métro, grandes surfaces, salles d'attente (= « au milieu, sans bord »)
- besoin d'un "bord" physique/social : rester près d'une porte, d'un proche « bienveillant ».
- évitements : visites à l'hôpital, rendez-vous dentaires, lectures "santé"...
- rituels d'hygiène prolongés.

Éléments d'examen :

- Pas de délire ni hallucinations.
- Anxiété élevée, attaques de panique circonstancielles.
- Insight partiel (« je sais que c'est excessif »).
- Fonctionnement global préservé hors contextes déclencheurs.

Lecture anthropo-phénoménologique :

Niveau anthropologique (spatialité non métrique) :

- direction de sens "en-deçà" : hantise du dépassement ; nécessité de revenir au bord
- centre vs périphérie : la plaque devient un centre qui aime la présence
- distance à autrui : vécue moralement/affectivement autant que physiquement

Niveau empirique/psychologique (thématisation symptomatique) :

- nosophobie : peur de devenir malade > évitements de soins/lieux médicaux, hyper-contrôle cutané
- paniques en situation « au milieu » (place, rame bondée) ; objets contraphobiques (accompagnement, siège près de la sortie).

Dimension	Niveau anthropologique	Niveau empirique
Espace	Non métrique : <i>centre/bord</i> , "en-deçà", auprès du Nous	Concret : hôpitaux, foules, métro
Temporalité	Ouverture vs blocage du possible	Anticipations anxieuses, évitements
Clinique	Hantise de l'outrepassement	Nosophobie, panique, rituels

1.2. L' « en deçà » phobique et l' « au-deçà » hystérique

Une relation particulière à la limite :

« Cette situation existentielle phobique se caractérise donc par la hantise de l'outrepassement et la nécessité de rester toujours bien avant la limite, en ce lieu désigné « deçà ». Il n'y a pas tant fuite que retrait. Le retrait est une expression du deçà. » (G. C.)

La situation critique : le "trop loin"

"Au-deçà" : entre "en-deçà" et "au-delà" :

- position phobique : se mettre derrière sa ligne de protection
- position hystérique : sortir du retrait pour se mettre en avant

Exemple clinique : agoraphobie

Julien, 27 ans, étudiant. Depuis 2 ans : agoraphobie et phobie sociale modérée. Amphi, places publiques, supermarchés problématiques.

Installation (6–8 mois).

Repère et trace mentalement une limite (rangée du fond, bord d'allée, proximité de la porte). Panique si cette limite est dépassée : « Si je passe la ligne, je me perds. »

Situations :

- Besoin d'un bord visible (porte, mur, personne « ressource »).
- Trop-loin = milieu : « assis au centre, je n'ai nulle part où me replier ».
- Retrait rapide en arrière (« en-deçà ») dès prémices d'angoisse : sueurs, vision tunnel.
- Évitements : présentations orales, files d'attente longues, grandes places.

Examen :

- Pas de délire/hallucinations
- Anxiété anticipatoire
- Quelques attaques de panique situationnelles
- Insight partiel

Lecture phénoménologique :

- limite constamment (ré-)élaborée
- l'en-deçà" = lieu et mouvement de retrait
- schème centre/bord : milieu est le trop-loin menaçant ; la présence se ré-abrite au bord

Exemple clinique : recherche de centralité

Inès, 29 ans. Chargée de communication. Expressivité riche, aisance relationnelle. Depuis un an, prise de parole fréquente en réunions, parfois sans préparation.

Installation / tableau actuel :

- Recherche répétée de positions très visibles ; sentiment d'« exister davantage » quand l'attention converge.
- Montée d'intensité ressentie à l'approche de l'intervention ; au-delà d'un seuil : tremblements, vertige fugace, malaise vasovagal court (sans perte de connaissance).
- Après-coup alternant euphorie (relief/triomphe) et honte ; malgré cela, recommence.

Paroles rapportées :

- « Quand je m'avance, tout devient plus net, plus vivant. »
- « Parfois c'est trop : je me sens happée. »
- « Si je reste en retrait, j'ai l'impression de disparaître. »

Examen :

- Pas d'éléments psychotiques.
- Affects labiles, tendance à la sur-exposition, malaises émotionnels brefs, récupération rapide.

Eléments cliniques ;

- rapport centre/bord : attraction vers des positions hautement exposées
- temporalité : sur-investissement de l'instant
- symétrie avec le phobique

Voies psychothérapeutiques :

- re-narrativiser l'instant
- mentaliser la topographie de l'exposition
- interventions en psycho-motricité

Tableau comparatif :

Dimension	En-deçà phobique	Au-deçà hystérique
Rapport à la limite	Garde la limite, retour derrière	Franchit la limite, avance vers le centre
Topologie	Bord = sécurité ; milieu = perte	Centre = existence/intensité ; bord = insignifiance
Mouvement	Retrait (évitement, repli)	Projection (exposition, emphase)
Crise	Panique du trop-loin (milieu)	Débordement d'intensité (liothymie, « trop-près du centre »)
Travail clinique	Exposition au milieu + dissoudre centre/bord	Re-narrativiser l'instant

1.3. La nostrité phobique

Cf. « De la nostrité », G. Charbonneau, in *L'art du Comprendre*, n°9, Paris, 2000 et « nostrité alcoolique », D. Pringuey, *L'art du Comprendre*, n° 10, Paris, 2001.

Exemple clinique : nostrité phobique

Cette vignette illustre que, pour le phobique, l'enjeu n'est pas d'éviter les autres, mais de rester aux « bords d'un Nous » sans s'exposer.

Maël, 33 ans Nouveau poste dans une équipe de 12. Antécédents d'anxiété sociale modérée. Recherche active de collectifs (course, chorale, coworking), changés tous les 3-6 mois.

Installation / comportements repérables (6 mois) :

- Arrive en avance, choisit systématiquement une place près de la porte, à l'extrémité de la table.
- Participe aux afterworks si un collègue familier est présent.
- Dans les groupes loisirs : dernier rang, extrémité du cercle ; se retire quand une mini-fonction visible lui est proposée (p. ex. animer l'échauffement).

Données d'examen :

- Pas de délire ni hallucinations
- Anxiété sociale, évitements situationnels, malaises vasovagaux brefs lors de prises de parole
- Insight partiel (« je me mets à l'écart »)
- Fonctionnement global correct mais appartenances instables

Lecture phénoménologique :

- nostrité : recherchée comme abri
- schème centre / bord : bord = possibilité de repli ; centre = vécu de trop loin (perte du repli)
- temporalité : imminence anxieuse avant les tours de table
- mobilité des nostrités (profil phobique)

Pistes de travail (?)

1.4. Anthropologie différentielle de l'« en-arrière » et de l'« en-avant »

Positions existentielles

Distinctions des positions existentielles :

- psychotiques :
 - être en arrière de soi mélancolique
 - être en avant de soi maniaque
- névrotiques :
 - être au deçà de soi hystérique
 - être en-deçà de soi phobique

Comparatif "arrière" :

Dimension	Mélancolie (en arrière de soi)	Phobie (en-deçà de soi)
Position existentielle	En arrière de soi : coupure avec le monde commun, retrait absolu.	En deçà de soi : retrait devant une limite vécue, mais présence maintenue.
Rapport au monde	Rupture franche : impossibilité de rejoindre le monde partagé.	Repli partiel : le monde reste accessible, mais limité par l'angoisse du « trop loin ».
Présence	Présence effondrée, discontinue.	Présence préservée, mais entravée.
Temporalité	Temps figé dans le passé, culpabilité irrémédiable.	Temps encore équilibré entre passé, présent et futur, mais sous tension.
Culpabilité	Ontologique : dette radicale, inéluctable (délires de culpabilité).	Culpabilités labiles, ponctuelles, sans portée ontologique (« micro-culpabilités »).
Ipséité	Fragilisée, engagée pathétiquement (« tout son être » en jeu).	Préservée, ne met pas en péril le sentiment d'identité fondamentale.
Symptôme clinique typique	Délires mélancoliques de culpabilité, rupture du lien social.	Phobie sociale, agoraphobie, inhibition, mais continuité de la présence.

Comparatif "avant" :

Dimension	Hystérie (au-deçà de soi)	Manie (en avant de soi)
Position existentielle	Franchissement de la ligne de retrait vers des positions hautement visibles (centrales), mais retour possible.	Projection au-delà des limites usuelles : propulsion vers l'initiative et l'extériorité, dépassement durable des bornes.
Rapport au monde	Monde recherché comme scène d'intensité ; besoin du regard d'autrui pour valider.	Monde vécu comme illimité / hyper-ouvert ; tout semble relié, disponible, pertinent.
Présence	Préservée, mais déstabilisée par l'intensité (débordements brefs : lipothymies, panique d'exposition).	Expansive, parfois envahissante ; si traits psychotiques : ruptures partielles (idées de grandeur, méconnaissance du risque).
Temporalité	Sur-investissement de l'instant (imminence, « coup de projecteur ») au détriment du récit et de la préparation.	Protension hypertrophiée : fuite en avant, accélération, projets multiples ; présent emporté par l'« à-venir » immédiat.
Affect principal	Intensité labile : exaltation > honte / embarras > re-quête d'intensité.	Exaltation / irritabilité, sentiment de puissance, réduction de l'auto-critique.
Ipséité	Sentiment de soi conservé ; style auto-centré sur la centralité-intensité.	Gonflement du pouvoir-être ; risque d'auto-déliaison (surestimation de soi / minimisation des limites).
Schème centre / bord	Aimantation du centre (visibilité) ; le retour au bord apaise.	Le centre se déplace partout : difficulté à retrouver un bord, dispersion.
Symptôme clinique typique	Sur-exposition, prises de parole impulsives, malaise vasovagal d'émotion, théâtre relationnel.	Fuite des idées, logorrhée, dépenses / conduites à risque, insomnie sans fatigue ; ± idées de grandeur.

Culpabilité

Formes de culpabilité selon quatre configurations existentielles :

- Phobie : culpabilité instrumentale, labile, sans thème ontologique.
- Hystérie : culpabilité-honte liée à la centralité et à l'instant.
- Manie : culpabilité écrasée par l'élan ; revient après.
- Mélancolie : culpabilité absolue, engageant le Soi et la temporalité (futur fermé).

Dimension	Phobie (en-deçà)	Hystérie (au-deçà)	Manie (en avant)	Mélancolie (en arrière)
Type de culpabilité	Micro-culpabilités labiles, circonstancielles	Culpabilité-honte après sur-exposition	Faible/ajournée pendant l'épisode ; retour post-manie	Culpabilité ontologique (dette irrévocable)
Déclencheurs	Franchir la limite (trop loin du bord), petites « transgressions » de rôle	Écart entre intensité recherchée et contrôle ; « trop au centre »	Conduites expansives, transgressions de limites (souvent sans ressenti immédiat)	Vécus de faute d'être, de ruine morale ; parfois sans faits repérables
Temporalité	Brève, réversible, se dissipe en repli	Après-coup court : triomphe > honte	Protension hypertrophiée : culpabilité minimisée ; retour en phase eutthyme/dépressive	Figée : passé inéluctable, futur fermé
Objet visé	« Je n'ai pas assez donné », « j'ai fui »	« J'ai trop pris la place », mise en scène de soi	« J'ai dépassé » (souvent reconnu après)	« Je suis indigne / coupable d'être »
Qualité affective	Discrète, utilitaire (régule l'exposition)	Honte + culpabilité, oscillante	Euphories qui anesthésient la faute ; irritabilité	Gravité tragique, accablement, auto-accusation
Rapport Moi / Soi	Moi (rôles, règles) ; ipséité préservée	Moi auto-centré (centre/bord) ; ipséité stable	Moi débordé par l'essor protensif ; ipséité gonflée	Atteinte du Soi (forme de présence) : dette qui engage « tout l'être »
Fonction / issue	Signal d'ajustement > repli, évitement	Régulation d'intensité (retrait,	Peu régulatrice sur le moment ; risque d'après-	Expiation / auto-punition ; risque

Dimension	Phobie (en-deçà)	Hystérie (au-deçà)	Manie (en avant)	Mélancolie (en arrière)
		puis re-quête d'intensité)	coup massif	suicidaire
Expression corporelle	Tension, panique de bord, parfois malaise	Lipothymies, tremblements de scène	Hyperactivité, insomnie sans fatigue	Ralentissement, anhédonie, douleur morale
Narrativité	Récits pragmatiques (« j'aurais dû... »)	Récits centrés sur la scène et le regard	Grand récit euphorique ; minimisation des torts	Monologue de faute, idées délirantes de culpabilité
Risque clinique	Évitements, restriction de vie sociale	Sur-exposition répétée > épuisement/honte	Conduites à risque, dettes, conflits	Suicide, nullité d'espoir, retrait radical
Leviers thérapeutiques	Travailler la périphérie active, redéfinir le « suffisant »	Réguler l'intensité, préparer/raconter l'instant, boucles centre > bord	Cadre et co-régulation du rythme, anticipation des réparations	Soutien existentiel, dés-ontologiser la faute, ouvrir la protension, sécuriser le risque

2. Les symptômes phobiques et leurs sens anthropologique

2.1. L'agoraphobie

L'agoraphobie : symptôme paradigmatique (l'espace y est vécu à l'état pur)

« L'espace est vécu comme un lieu d'exposition où le risque de perte au milieu et trop loin du bord est constamment dessiné et projeté. » (G. C.)

La "limite" : la ligne de partage entre le familier et l'espace de perte

Le "trop loin du bord" (qui peut être le milieu) structure l'espace

Le vertige agoraphobique/acrophobique :

- une brusque désorganisation de l'espace vécu, une confusion de l'ici et là
- une impulsion à aller vers le "milieu"
- une peur de ne pas pouvoir retrouver le "bord"
- une hantise de se perdre dans l'*au-delà de soi*

2.2. La claustrophobie

La claustrophobie (problème similaire) :

- être au milieu et empêché de retourner vers le bord (= la sortie)
- "être enfermé" = être *sans autrui proche*
- ou parfois inversement : angoisse due à la trop grande proximité d'autrui

Francesetti Gianni, Belasco Florence, « Perspective de la Gestalt-thérapie. Clinique des attaques de panique », *Le Journal des psychologues*, n° 359, 2018/7, p. 52-57.

2.3. Les phobies sociales

- peur être perdu au milieu d'une foule, du "trop habité"
 - un espace social trop "profond", sans proximité bienveillante
- = peur liée à la dislocation des structures anthropologiques familiales protectrices

2.4. La nosophobie

La maladie porte le sens de la perte d'autrui : un brusque *trop-loin*

2.5. Les « moments critiques »

La crise agoraphobique (attaque d'angoisse) est déterminée par :

- la perte des repères entre le bord et le milieu
- accompagnée d'une recherche panique du bord

La crise d'hystérie : une surdétermination de la centralité

La crise de spasmophilie : à la fois phobique et hystérique

3. La relation hystérique et phobique à la centralité

3.1. Centralité et intensité dans l'hystérie. La perte dans l'instant

La centralité comme position existentielle

> on peut se perdre dans l'instant, dans l'imminence (de l'événement)

L'hystérie est une pathologie de l' "instant-intensité" comme elle l'est de la "centralité-intensité".

Exemple clinique : La perte dans l'instant

Élise, 26 ans, responsable RH, passionnée de scène (slam). Pas d'antécédents psychiatriques majeurs.

Vie sociale dense, forte présence en ligne.

Multiplication des prises de parole improvisées.

Sensation d'ivresse en direct, suivie d'épuisement et de malaise lipothymique à plusieurs reprises > demande de consultation

Vécus rapportés :

« *L'instant m'aspire. Il ne reste que moi et les regards.* »

- Aimantation : avance spontanément au centre, cherche les regards.
- Intensité montante : chaleur, fourmillements, « zoom » sur les visages, bruit étouffé.
- "Perte dans l'instant" : « Le monde se dissout ; je deviens la scène. »
- Après-coup : trou mnémonique partiel du passage, exaltation > honte, ruminations, posts supprimés.
- Conduites : surenchère d'événements « pour revivre ça », préparation quasi nulle (« ça doit être pur »).

Données d'examen :

- pas de délire ni hallucinations.
- affect labile, théâtralité modérée
- lipothymies d'émotion sans perte de connaissance
- insight fluctuant (« je sais que je force, mais j'en ai besoin »)

Lecture phénoménologique :

- topologie : attraction centrale
- Temporalité : tyrannie de l'instant-intensité
- Soi / Moi : le Soi se décorpore partiellement

Orientations thérapeutiques :

- restituer du bord (espace)
- restituer du récit (temps : avant/pendant/après)
- désaturer le centre

Posture et cadre :

- suspendre l'explication causale (épochè clinique)
- décrire et éclairer la manière d'être-au-monde (forme de présence)
- constituer une alliance phénoménologique
- être co-enquêteur·rice du vécu

- sans chercher à corriger, ni à convaincre

Phase I : clarification descriptive

- déplier plutôt qu'expliquer
- construire une représentation de la structure de présence

Phase II — Habiter autrement l'espace et le temps

- corporéité vécue
- scénographie du regard

Phase III — Ré-ouvrir la temporalité (du kairos au récit)

- support cognitif : reconstitution des séquences rétention-protention
- support narratif : enveloppement dans un récit

Phase IV — Repositionnement des rôles (idem) et du sens (ipse)

- évaluation des rôles et de leurs styles
- dé-essentialiser les rôles
- redéfinir les valeurs/axes d'existence > remobiliser un autre "pouvoir être"

Appréciation qualitative de l'évolution

- le patient peut rester en périphérie sans se dissoudre
- il peut aller au centre sans se perdre
- l'instant devient séquencé
- moins de lipothymies
- le récit de soi se densifie

3.2. Typification hystérique des identités de rôle

Saturation des identités de rôle :

Type de rôle	Exemple hystérique typique	Commentaire phénoménologique
Sexuel / affectif	Hyperféminité / amant passionné	Exagération du rôle, saturation de l'identité affective, centralité du désir et du regard d'autrui.
Familial / professionnel	La mère parfaite / le grand professeur	Incarnation emphatique de figures centrales, recherche de reconnaissance par le rôle social.
Religieux / existentiel	Le mystique, le prophète, le sage	Mise en scène d'une identité transcendante, emphase sur l'unicité de sa place dans le monde.

Comparaison hystérie/phobie :

Phobique	Hystérique
Fuit les rôles trop visibles, craint l'exposition.	Cherche les rôles centraux, s'expose au regard.
Préfère l'anonymat, le bord, la discrétion	Vise la centralité, l'intensité, la visibilité.
Angoisse : être au centre sans pouvoir revenir en retrait.	Angoisse : perdre la centralité, tomber dans l'indifférence.

Annexes - Usages professionnels et lieux d'exercice

Compétences patho-cliniques pertinentes pour :

- les situations intermédiaires (entre normal et pathologique lourd)
- le mal-être ordinaire et la souffrance diffuse
- les transitions de vie (déménagement, entrée en institution, perte d'autonomie)
- les pathologies chroniques nécessitant une réorganisation existentielle

> Accompagnement/rétablissement versus "traitement" :

- dimension écologique de la santé psychique
- co-construction du sens avec la personne
- restauration de la " confiance ontologique " vs suppression de symptômes
- accompagnement plutôt que "correction"

Gériatrie et gérontologie

Institutions et associations (sanitaires et médico-sociales) :

- EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- USLD (Unités de Soins de Longue Durée)
- Résidences autonomie (ex foyers-logements)
- Accueils de jour
- SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)
- UCC – Unités Cognitivo-Comportementales (troubles du comportement sévères)
- Plateformes de répit (soutien aux aidants)
- SAAD – Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
- Soins palliatifs (unités ou équipes mobiles)

Enjeux cliniques :

- Transition résidentielle : perte du " chez-soi habituel " + nécessité de familiariser un nouvel espace
- Désorganisation temporo-spatiale : troubles cognitifs affectant simultanément les routines et le repérage spatial
- Perte d'autonomie : difficulté dans les gestes quotidiens + transformation du rapport à l'espace domestique

Contextes d'interventions :

- L'hébergement vécu comme exil possible
- Maintien des routines personnelles (horaires de lever, rituels du matin)
- Personnalisation de l'espace (chambre avec objets familiers)
- Création de repères spatio-temporels (calendrier, organisation spatiale claire)
- Accompagnement de la familiarisation progressive avec les lieux collectifs
- Travail sur les seuils (porte de chambre, couloir, salle commune)
- Appropriation symbolique (objets, photos, odeurs) et pas seulement fonctionnelle

Psychiatrie et santé mentale

Institutions (voir hôpitaux et centres de soins associatifs) :

- Hôpitaux psychiatriques (services d'hospitalisation complète)
- Hôpitaux de jour psychiatriques
- CMP (Centres Médico-Psychologiques)
- CATTP (Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel)
- CSAPA (Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
- Appartements thérapeutiques
- Centres de post-cure
- ACT – Appartements de Coordination Thérapeutique
- Équipes mobiles psychiatrie-précarité
- Clubs thérapeutiques

Enjeux cliniques :

- Accompagnement vers le logement autonome : routines + familiarisation spatiale
- Capacité à s'installer (se poser, rester, revenir)

Cadres d'interventions :

- Ateliers de réhabilitation psychosociale : gestes quotidiens (cuisine, entretien) et aménagement d'espace
- Groupes de médiation/médiateur en santé mentale : structuration temporelle et appropriation de lieux partagés
- Micro-structures du quotidien (petits possibles, rendez-vous-rituels)
- Art-thérapie, ergothérapie : travail sur le corps vécu, l'espace, les rythmes
- Travailleurs pairs
- Médiateurs en santé mentale
- Conseillers en insertion
- Parcours de rétablissement

Cadres sociaux et médicaux-sociaux

Institutions pour l'hébergement et l'insertion :

- CHRS (Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale)
- CHU (Centres d'Hébergement d'Urgence)
- Maisons relais / Pensions de famille
- Centres maternels
- Foyers de jeunes travailleurs
- CADA (Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile)
- Foyers d'accueil médicalisés (FAM)
- Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS)
- Associations type "Un chez-soi d'abord"
- Médiation sociale, pair-aidance

Contextes spécifiques :

- Absence de "chez-soi" : pas de routines stables + déracinement spatial
- Précarité : quotidien chaotique et errance spatiale
- Migration/exil : perte des repères culturels quotidiens + déterritorialisation complète
- Handicap : difficultés dans les actes de la vie quotidienne + besoin d'adaptation spatiale

Contextes d'interventions :

- Création de repères minimaux (horaires de repas, lieu personnel)
- Ritualisation sécurisante : moments réguliers, espaces identifiés
- Accompagnement de la réappropriation : "faire sien" un espace temporaire
- Travail sur la projection : imaginer un futur quotidien et spatial stable

Addictologie

Institutions :

- CSAPA – Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (déjà cités)
- CAARUD – Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues
- LHSS – Lits Halte Soins Santé
- ACT – Appartements de Coordination Thérapeutique
- Communautés thérapeutiques

Apport conceptuel spécifique :

- L'addiction comme rétrécissement spatio-temporel du monde
- Notion de lieux à risque / lieux ressources
- Le "chez-soi" comme espace ambivalent (protection / tentation)

Réadaptation et rééducation

Institutions :

- SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
- Centres de rééducation fonctionnelle
- Services d'ergothérapie
- Unités neuro-vasculaires
- Centres de rééducation neurologique
- IME – Instituts Médico-Éducatifs
- SESSAD – Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
- SAMSAH – Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
- SAVS – Services d'Accompagnement à la Vie Sociale
- Plateformes TSA – Troubles du Spectre de l'Autisme

Enjeux cliniques :

- Perte de capacités physiques : impossibilité d'accomplir les gestes quotidiens + transformation du rapport au corps et à l'espace
- Maladie chronique : réorganisation complète du quotidien ET adaptation de l'habitat
- AVC, traumatismes : réapprentissage des routines + modification du schéma corporel et spatial

Contextes d'interventions :

- Réentraînement aux activités de la vie quotidienne, reconstruction des continuités
- Adaptation de l'environnement : aménagement du domicile
- Reconstruction du schéma corporel dans l'espace vécu
- Notion de centre / dedans : absence de seuil, d'intimité (déracinement spatial, déterritorialisation)
- Accompagnement du retour à domicile : anticipation des nouvelles routines dans l'espace transformé
- Notions d'affordances, d'atmosphères, de sensorialité

Médecine du travail, pathologies professionnelles

Institutions :

- Services de santé au travail
- Consultations souffrance au travail
- Réseaux de prévention du burn-out
- Cellules d'accompagnement professionnel

Enjeux cliniques :

- Envahissement du quotidien par le travail : disparition des rythmes personnels + réduction de l'espace vital au bureau/travail
- Épuisement professionnel : perte des routines de récupération + impossibilité de "rentrer chez soi" psychologiquement
- Souffrance éthique : désajustement entre valeurs et pratiques quotidiennes
- Transition professionnelle (ex. "transition agro-écologique")

Cadres et objectifs des interventions :

- Restauration de frontières temporelles (travail/hors-travail)
- Réinvestissement de l'espace domestique comme lieu de ressourcement
- Reconstruction de rythmes protecteurs

Accompagnement post-traumatique

Institutions :

- Cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP)
- Centres de psychotraumatologie
- Unités victimologie
- Associations d'aide aux victimes

Enjeux cliniques :

- Hantise des lieux : certains espaces deviennent inhabitables
- Rupture du quotidien : impossibilité de reprendre les routines d'avant
- Hypervigilance : le familial (spatial et temporel) devient menaçant
- Intrusions : envahissement du quotidien et les lieux actuels par le passé traumatique

Cadres de l'intervention :

- Sécurisation de l'espace thérapeutique (stabilité du lieu, du cadre)
- Reconstruction narrative : réintégrer l'événement dans l'histoire de vie
- Réappropriation progressive des lieux et des routines
- Travail sur la confiance dans le monde (quotidien et spatial)

Soins à domicile et soins ambulatoires

Institutions, associations :

- Cabinets libéraux (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens)
- SSIAD, SPASAD (Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile)
- HAD (Hospitalisation à Domicile)
- Services d'aide à domicile
- Consultations CMP

Enjeux cliniques :

- Maintien à domicile : préservation des routines dans l'espace familial menacé
- Soutien aux patients et aidants : préservation de leur propre quotidien et espace
- Isolement : quotidien appauvri + rétrécissement de l'espace vécu
- Vieillesse : adaptation progressive du quotidien et de l'habitat

Protection de l'enfance et parentalité

Institutions :

- PMI – Protection Maternelle et Infantile
- ASE – Aide Sociale à l'Enfance
- AEMO – Action Éducative en Milieu Ouvert
- MECS – Maisons d'Enfants à Caractère Social

Apport spécifique :

- Le quotidien comme lieu central de la parentalité

- L'habiter comme condition de sécurité psychique de l'enfant

Étudiants, écoles

Institutions :

- BAPU – Bureaux d'Aide Psychologique Universitaires
- Services de santé universitaire
- Internats, dispositifs handicap

Clinique :

- Désorganisation du temps
- Difficulté à habiter un lieu étranger (chambre, colocation, campus)

Justice, pénitentiaire, réinsertion

Institutions :

- SPIP – Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation
- Milieu carcéral, semi-liberté, post-détention

Apport clinique :

- Transition d'un quotidien hyper-normé → quotidien à reconstruire
- Habiter des lieux parfois toxiques ou inconnus

Principes transversaux de l'intervention

Le quotidien et l'habiter sont des *organismes cliniques*

Le soin s'appréhende comme "re-quotidianisation" et "rétablissement" :

- restaurer la familiarité
- reconstruire la temporalité
- réancrer spatialement
- restaurer l'intersubjectivité, etc.

Table des matières

PRÉSENTATION

SOMMAIRE

I - PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA FATIGUE

1. Introduction
2. Clinique de la fatigue
 - 2.1. *Les « sentiments corporels »*
 - 2.1.1. *Le pré-sensoriel et le sensoriel*
 - 2.1.2. *Fatigue versus sensation*
 - 2.2. *Les vécus de fatigue*
 - 2.2.1. *Fatigue et états thymiques*
 - 2.2.2. *La dimension pré-réflexive de la fatigue*
 - 2.3. *Le « vécu de pouvoir »*
 - 2.3.1. *Le primat du possible*
 - 2.3.2. *La réduction du pouvoir-être*
 - 2.4. *Le « vécu de valoir »*
 - 2.4.1. *La valeur comme « appel du monde »*
 - 2.4.2. *L'altération du valoir*
3. Altérations du pouvoir : fatigue, épuisement
 - 3.1. *La fatigue physique, sans épuisement psychique*
 - 3.2. *Clinique différentielle*
 - 3.3. *Historialité de la fatigue*
 - 3.3.1. *Le temporel*
 - 3.3.2. *L'historial*
 - 3.3.3. *Les réactions abandonniques*
4. Altérations du valoir : ennui, acédie, dépression
 - 4.1. *Le champ dépressif et la fatigue psychogène*
 - 4.2. *L'acédie monastique, le « démon de midi »*
5. Altérations conjointes : mélancolie
 - 5.1. *Mélancolie versus dépression*
 - 5.2. *Fatigue ou inhibition dans la mélancolie*
6. Fatigues de défense : luttes anxieuses et ruminations
7. Synthèse clinique et phénoménologique

II - PHÉNOMÉNOLOGIE DU QUOTIDIEN

1. Introduction
 - 1.1. *Observations cliniques*
 - Patiente de 32 ans*
 - Homme de 28 ans*
 - 1.2. *Une structure à trois niveaux*
2. L'énigme du familier
 - 2.1. *Le quotidien comme mode de manifestation du monde*
 - 2.2. *Le double visage du quotidien*

- 2.3. *Le « Lebenswelt »*
- 3. Le quotidien comme « structure de l'expérience »
 - 3.1. *Les structures fondamentales du monde quotidien*
 - 3.2. *L'équilibre familial / étranger*
 - 3.3. *La spatialité quotidienne : un espace domestiqué*
 - 3.4. *La temporalité quotidienne : rythme, répétition, routine*
 - 3.5. *La socialité quotidienne*
 - Interactions et rôles*
 - Normativité : le permis et le possible*
- 4. Le processus de « quotidianisation »
 - 4.1. *La constitution du quotidien*
 - 4.2. *Une « genèse socio-transcendantale » du quotidien*
- 5. Clinique du quotidien
 - 5.1. *Le monde quotidien comme fond de toute santé psychique*
 - 5.2. *Les dérèglements de la quotidienneté*
 - Schizophrénie : perte de l'évidence et étrangeté du familial*
 - Dépression : le monde familial sans valeur*
 - Trouble obsessionnel : hypertrophie et procéduralisation du quotidien*
 - Anxiété : quotidien sous menace*
 - Addiction : rigidification artificielle du familial*
 - 5.3. *Le soin comme « re-quotidianisation »*

III - PHÉNOMÉNOLOGIE DE L'HABITER

- 1. Introduction
 - 1.1. *Observations cliniques*
 - Madame L., 38 ans*
 - Monsieur R., 52 ans, éleveur bovin*
 - 1.2. *Une structure existentielle*
 - 1.3. *Les différentes origines de la réflexion*
 - Heidegger : « Bâtir Habiter Penser »*
 - Bachelard : la « Poétique de l'espace »*
 - Bollnow : « L'homme et l'espace »*
 - Merleau-Ponty : la « chair du monde »*
 - Hoyaux « géographie et phénoménologie »*
- 2. L'habiter comme structure existentielle
 - 2.1. *L'habiter comme mode d'être*
 - 2.2. *La structure tripolaire de l'habiter*
 - Le corps comme condition existentielle*
 - Seuils et frontières*
 - 2.3. *L'habiter comme processus temporel de familiarisation*
 - Atmosphères et dimension pathique de l'espace*
 - Dimensions intersubjectives de l'habiter*
 - 2.4. *Figures existentielles de l'habiter*
 - 2.5. *Habiter, quotidien et bien-être*
- 3. Psychopathologie de l'habiter
 - 3.1. *L'agoraphobie : rupture de la familiarité spatiale*
 - 3.2. *La claustrophobie : enfermement spatial*

- 3.3. *La dépression : délabrement de l'espace habité*
 - 3.4. *La schizophrénie : désarticulation de l'espace vécu*
 - 3.5. *L'addiction : rétrécissement de l'espace vital*
 - 3.6. *Le traumatisme : hantise des lieux*
 - 4. Le « Soi territorial » et l'habitation du corps
 - 4.1. *Genèse du territoire : du corps au monde*
 - 4.2. *Les strates de territorialisation : du corps à l'espace habité*
 - 4.3. *Le « Soi territorial »*
 - 4.4. *Les pratiques quotidiennes de territorialisation*
 - 4.5. *Territorialisation et déterritorialisation*
 - 4.6. *Implications thérapeutiques et professionnelles*
- (Synthèse) Mr R. Analyse phénoménologique
- 1. *Problème central : une crise de l'habiter (vs "stress" de situation)*
 - 2. *La structure tripolaire de l'habiter est atteinte (III, 2.2)*
 - 2.1. *Atteinte du pôle 1 : l'ancrage corporel*
 - 2.2. *Atteinte du pôle 2 : le déploiement spatial (espace vécu)*
 - 2.3. *Atteinte du pôle 3 : la tonalité affective (atmosphères)*
 - 3. *L'habiter comme processus temporel : perte secondaire de familiarisation (III, 2.3)*
 - 4. *Les possibilités pour l'action disparaissent : le milieu professionnel perd sa lisibilité*
 - 5. *Figures existentielles de l'habiter (III, 2.4) : rigidification et effondrement partiel*
 - 6. *Territorialisation / déterritorialisation : atteinte du "Soi territorial" (III, 4)*
 - 6.1. *Déterritorialisation sans déménagement*
 - 6.2. *Atteinte des strates de territorialisation (du corps au monde)*
 - 6.3. *Le Soi territorial fragilisé*
 - 7. *Seuils et frontières : indices cliniques à expliciter*
 - 8. *Hypothèse synthétique*
 - 9. *Ouverture clinique : "reterritorialisation" concrète (III, 4.6)*
 - 10. *Ne pas confondre les perspectives psychothérapeutiques*

IV - PHÉNOMÉNOLOGIE DES NÉVROSES : « L'ÊTRE EN DEÇÀ DE SOI » (PHOBIE, HYSTÉRIE)

- 1. La spatialité vécue. Espace empirique et espace vécu
 - 1.1. *Niveau anthropologique et niveau psychologique*
Exemple clinique : nosophobie à structure spatiale (non métrique)
 - 1.2. *L'« en deçà » phobique et l'« au-deçà » hystérique*
Exemple clinique : agoraphobie
Exemple clinique : recherche de centralité
 - 1.3. *La nostrité phobique*
Exemple clinique : nostrité phobique
 - 1.4. *Anthropologie différentielle de l'« en-arrière » et de l'« en-avant »*
Positions existentielles
Culpabilité
- 2. Les symptômes phobiques et leurs sens anthropologique
 - 2.1. *L'agoraphobie*
 - 2.2. *La claustrophobie*
 - 2.3. *Les phobies sociales*
 - 2.4. *La nosophobie*

2.5. Les « moments critiques »

3. La relation hystérique et phobique à la centralité

3.1. Centralité et intensité dans l'hystérie. La perte dans l'instant

Exemple clinique : La perte dans l'instant

3.2. Typification hystérique des identités de rôle

ANNEXES - USAGES PROFESSIONNELS ET LIEUX D'EXERCICE

Gériatrie et gérontologie

Psychiatrie et santé mentale

Cadres sociaux et médicaux-sociaux

Addictologie

Réadaptation et rééducation

Médecine du travail, pathologies professionnelles

Accompagnement post-traumatique

Soins à domicile et soins ambulatoires

Protection de l'enfance et parentalité

Étudiants, écoles

Justice, pénitentiaire, réinsertion

Principes transversaux de l'intervention

Table des matières

